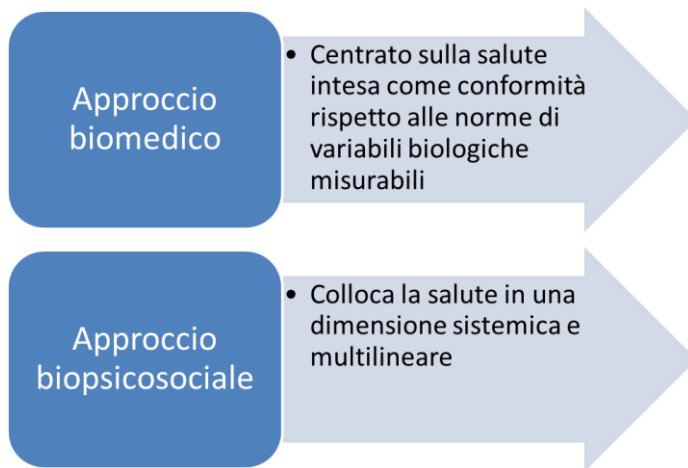


DAL MODELLO BIOMEDICO AL MODELLO BIOPSICOSOCIALE

Verso la fine degli anni Settanta del secolo scorso, lo sviluppo del pensiero e delle pratiche della medicina, l'ampliamento degli orizzonti epistemologici e degli scenari epidemiologici esplicitano un cambiamento nel pensiero sulla salute

Il dibattito sembra focalizzarsi nel confronto tra un approccio biomedico tradizionale e un nuovo approccio emergente, bio-psicosociale.



Modello Biomedico

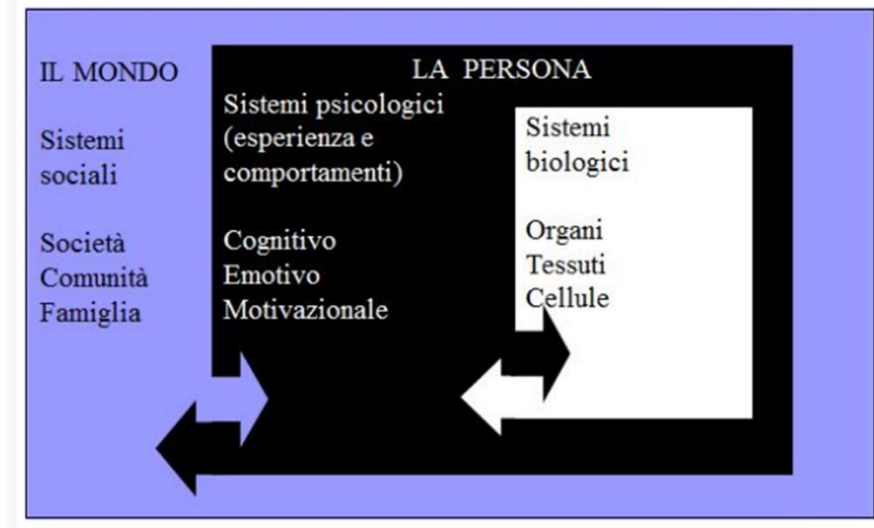
- Ogni malattia ha una causa biologica primaria, oggettivamente identificabile (=deviazione dalla norma di variabili biologiche misurabili)
- Nella diagnosi non entrano i fattori comportamentali e socio-psicologici, che vengono spiegati con processi biochimici e neurofisiologici disturbati e non come cause potenziali di malattia.

Conseguenze di tale concezione:

- concede poco spazio all'azione preventiva (volta a ridurre l'incidenza delle malattie croniche tramite cambiamenti nelle credenze, atteggiamenti e comportamenti relativi alla salute)
- enfatizza il potere attivo degli operatori sanitari, promuovendo una posizione passiva nel paziente.
- fornisce una visione riduzionistica = i fenomeni complessi derivano da 1 singolo principio primario
- implica un dualismo mente/corpo: per cui il mentale viene separato dal somatico

Modello Biopsicosociale

L'assunzione fondamentale del modello biopsico-sociale è che ogni condizione di salute o di malattia sia la conseguenza dell'interazione tra fattori biologici, psicologici e sociali (Engels, 1977, 1980; Schwartz, 1982).



- E' un modello integrativo, basato sulla teoria generale dei sistemi, che superando il riduzionismo e il dualismo del tradizionale modello medico, sostiene che alla base delle alterazioni della salute ci sia un' interazione dinamica di più fattori.
- Sulla base di questo, la diagnosi medica va a considerare l'interazione degli aspetti biologici/psicologici/sociali nel valutare lo stato di salute e prescrivere la terapia. In tale modello si enfatizza, pertanto (Bertini, 1988): - sia la specificità dei livelli di analisi della complessità dell'organismo - sia l'interdipendenza o l'integrazione tra i livelli.
- Si approfondisce il livello psicologico e sociale
- Ci si orienta sulla salute globale della persona nel suo ambiente
- Si enfatizza di + la promozione della salute (intesa come realizzazione di sé ed esplorazione del nuovo) che la prevenzione della malattia
- Si tiene conto delle necessità di interazione o integrazione tra i vari livelli di analisi (=interdisciplinarietà) e i diversi ruoli professionali (=multiprofessionalità)

Conseguenze di tale concezione:

- psiche e corpo sono indivisibili (i malesseri fisici si ripercuotono sulla psiche e viceversa)
- Si sottolinea il carattere dinamico del rapporto fra individuo e ambiente (sottolineando l'instabilità di tale rapporto). Un individuo viene considerato: - "sano": quando è in armonia con il proprio ambiente interiore ed esteriore - "malato": quando prevale la disarmonia.
- Viene messa in evidenza l'influenza sullo stato di salute di fattori ambientali e sociali (fame, disoccupazione, emarginazione, stress, inquinamento ecc.)
- La "salute", quindi, non è solo il benessere derivante dal buon funzionamento dell'organismo, ma è il risultato dell'interazione dell'ambiente con l'individuo.

SISTEMA → Un'implicazione importante del modello biopsicosociale è l'esplicito riferimento al concetto di sistema, sviluppato da L. von Bertalanffy (1968), inteso come un'entità dinamica in cui le componenti sono in continua e reciproca interazione, in modo da formare un'unità o un tutto organico (cfr. Stone, 1987).

SALUTE → “STATO DI COMPLETO BENESSERE FISICO, MENTALE E SOCIALE E NON SEMPLICE ASSENZA DI MALATTIA O INFERMITÀ”
(Definizione della OMS, 1948)

L'età contemporanea esordisce con una progressiva presa di consapevolezza che le vicende di salute e di malattia richiedono una visione più complessa di quanto non potesse sembrare necessario solo alcuni decenni fa.

Oggi il panorama delle definizioni di salute e di malattia tiene ampiamente conto di questa accresciuta consapevolezza che non riguarda solamente il dibattito scientifico e gli “addetti ai lavori”, ma coinvolge direttamente ampi settori culturali, l'opinione pubblica e condiziona atteggiamenti sociali e scelte comportamentali a livello individuale e collettivo.

Sempre di più la salute è considerata contemporaneamente un bene personale e un bene sociale e, come tale, la responsabilità della sua tutela spetta egualmente al soggetto, alla comunità familiare, alla collettività sociale e, naturalmente, in primo luogo alle agenzie pubbliche che hanno ricevuto il mandato di presidiare la salute dei cittadini, cioè, nel nostro Paese, al Sistema Sanitario Nazionale.

Due principali orientamenti culturali

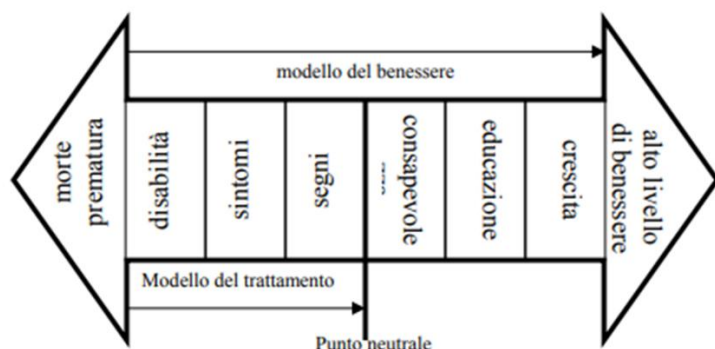
- Il primo orientamento è rappresentato da una concezione “clinica” della salute, centrata sui sintomi e sulla disabilità, contrapposti ad una condizione di benessere
- il secondo orientamento si basa su una visione più ampia e non lineare che può forse essere organizzata verso una concezione della salute di tipo ecologico e della complessità.

Modello Clinico

- La salute è intesa, negativamente, come assenza di malattia e la malattia è definita dalla cospicua presenza di segni e sintomi patologici.
- Il modello focalizza la dimensione del trattamento in rapporto alle condizioni di patologia conclamata o di concreta minaccia di malattia, mettendo in secondo piano la prevenzione e il ruolo del paziente nelle cure

Continuum benessere-malessere

In questa concezione salute e malattia muovono da un estremo rappresentato da un alto livello di benessere a un altro estremo rappresentato dalla mancanza di salute. Un altro livello di benessere è caratterizzato da un elevato senso di soddisfazione e dalla qualità della vita.



Differenze

A differenza di un modello clinico più arcaico, nel modello del continuum benessere-malessere il trattamento non si limita a contrastare segni, sintomi e disabilità, ma persegue positivamente il miglioramento della salute, privilegiando strumenti educativi e di coinvolgimento diretto delle persone.

Ricadute

Svariate indagini mostrano che gli utenti dei sistemi sanitari sono insoddisfatti degli aspetti relazionali, comunicativi ed informativi, si sentono poco presi in considerazione come persone.

Del resto la medicina si è tradizionalmente organizzata per curare corpi piuttosto che individui, e le organizzazioni sanitarie sono condizionate da una serie di fattori che portano ad offuscare i bisogni e la dimensione soggettiva degli utenti.

Alcune criticità evidenziate dalle associazioni dei malati

Tab. I. Alcune criticità evidenziate dalle associazioni dei malati.	
Medicina di base	% di segnalazioni
Scarsa formazione verso il paziente sulla gestione della patologia	75,00%
Poco tempo per l'ascolto	43,75%
Assenza di figure professionali adeguate per alcuni bisogni di salute	41,76%
Specialistica territoriale	% di segnalazioni
Scarsa formazione/informazione al paziente sulla gestione della patologia	56,25%
Poco tempo dedicato all'ascolto	43,75%
Assenza/scarsa valutazione multidisciplinare delle esigenze di salute	31,25%
Assistenza domiciliare	% di segnalazioni
Assenza della figura dello psicologo	58,82%
Ospedale	% di segnalazioni
Assenza di servizi di intervento psicologico	72,92%
Mancata valutazione multidimensionale dei bisogni di salute	52,08%
Carenza di integrazione tra le figure sanitarie	42,00%

Fonte: Rapporto CnAMC 2010.

PROMOZIONE DELLA SALUTE

Nel 1986 l'OMS presenta la Carta di Ottawa in cui, nel contesto della promozione della salute, la salute viene considerata non tanto una condizione astratta, quanto un mezzo finalizzato a un obiettivo che, in termini operativi, si può esprimere come una risorsa che permette alle persone di condurre una vita produttiva sotto il profilo personale, sociale ed economico.

SALUTE → mezzo per raggiungere gli obiettivi

La salute è una risorsa per la vita quotidiana e non lo scopo dell'esistenza. È un concetto positivo che mette in evidenza le risorse individuali e sociali, come pure le capacità fisiche.

Conformemente al concetto di salute, **inteso come un diritto fondamentale dell'uomo**, la Carta di Ottawa evidenzia alcuni **requisiti fondamentali per la salute fra i quali:**

- **la pace**
- **adeguate risorse economiche**
- **l'alimentazione**
- **l'abitazione**
- **un ecosistema stabile**
- **uso sostenibile delle risorse**

Il riconoscimento di questi requisiti fondamentali sottolinea gli inestricabili **legami esistenti tra le condizioni socioeconomiche, l'ambiente fisico, lo stile di vita delle persone e la salute.**

Questi legami forniscono la chiave di **comprensione olistica della salute**, fondamentale nella definizione di promozione della salute.

La promozione della salute è il processo che consente alle persone di acquisire un maggior controllo della propria salute e di migliorarla.

La promozione della salute rappresenta un processo sociopolitico globale. Esso investe non soltanto le azioni finalizzate al rafforzamento delle capacità e delle competenze degli individui, ma anche l'azione volta a modificare le condizioni sociali, ambientali e economiche in modo tale da mitigare l'impatto che esse hanno sulla salute del singolo e della collettività.

La Carta di Ottawa individua tre strategie fondamentali per la promozione della salute:

1. **perorare la causa della salute per creare quelle condizioni essenziali per la salute citate in precedenza,**
2. **permettere a tutte le persone di sviluppare al massimo le loro potenzialità di salute e**
3. **mediare tra i diversi interessi esistenti nella società, al fine di perseguire la salute.**

A queste strategie sottendono 5 campi di azione prioritari :

1. **creare sane politiche pubbliche:** (per es. orientare sulla promozione della salute le politiche sociali, agricole, del trasporto, della pianificazione urbana);
2. **creare ambienti favorevoli alla salute:** (per esempio scuole, contesti lavorativi, ecc.);
3. **rafforzare l'azione collettiva a favore della salute:** (rafforzare i processi di partecipazione dei cittadini alla formulazione, implementazione e valutazione di politiche che influiscono sulla promozione della salute);
4. **sviluppare le capacità individuali/develop personal skills:** (per meglio affrontare decisioni inerenti la salute individuale e della comunità);
5. **riorientare i servizi sanitari/re-orient health services:** (per es. sulla promozione della salute, e non solo sulla cura)

Non è possibile conquistare il massimo potenziale di salute se non si è in grado di controllare i fattori determinanti della salute.

DETERMINANTI DELLA SALUTE → I determinanti della salute sono i fattori che influenzano lo stato di salute di un individuo e – più estesamente – di una comunità o di una popolazione.

Determinanti della salute possono essere raggruppati in varie categorie:

- **comportamenti personali e stili di vita;**
- **fattori sociali che possono rivelarsi un vantaggio o uno svantaggio;**
- **condizioni di vita e di lavoro;**
- **accesso ai servizi sanitari (SSN) → IMMIGRAZIONE SANITARIA;**
- **condizioni generali socio-economiche, culturali e ambientali;**
- **fattori genetici.**

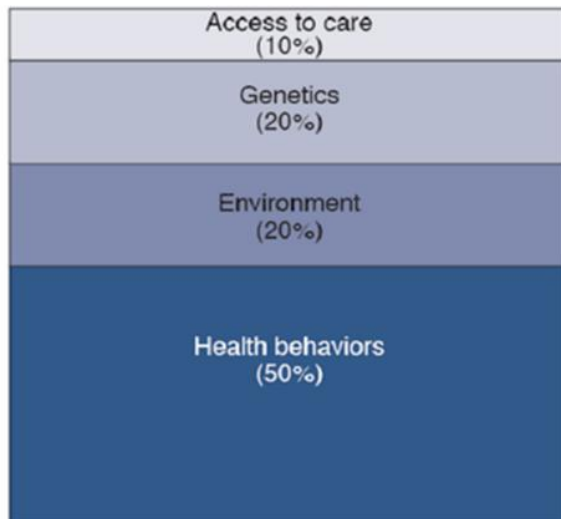
3 MODELLI → come si incastrano le varie determinanti,

Le discussioni iniziano quando si propongono modelli concettuali che pongono in evidenza un fattore piuttosto che un altro, quando stabiliscono una gerarchia di valore tra i vari elementi.

I modelli concettuali rappresentati sono profondamente diversi e propongono antitetiche strategie di sanità pubblica.

Primo modello→ USA

Slide 1. Determinanti della salute (USA)



Source: IFTF; Centers for Disease Control and Prevention.

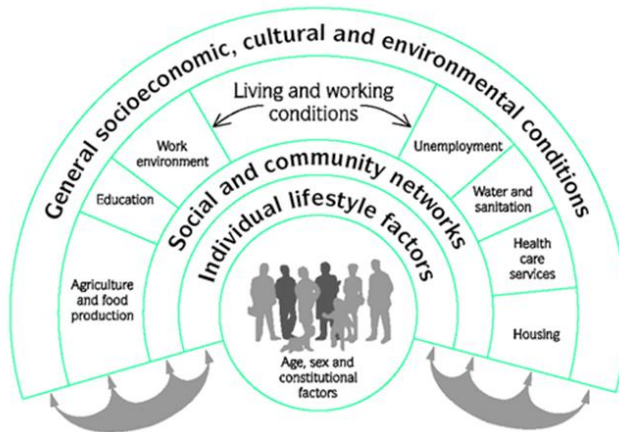
- Lo stato di salute delle persone sarebbe condizionato per il 50% dai loro comportamenti e dal loro stile di vita.
- Meno importanti gli altri fattori: fattori ambientali (20%), fattori genetici (20%), assistenza sanitaria (10%).
- Questo modello mette in primo piano il ruolo gli stili di vita delle persone e rispecchia l'enfasi che negli USA viene posta sulla responsabilità individuale nei confronti di salute e malattia→ **ENFASI SU PERSONA, SU RESPONSABILITA' INDIVIDUALE DELLA PERSONE**

IN BASE AL MODELLO APPLICHO POLITICHE SANITARIE DIFFERENTI

Secondo modello → EUROPA

Slide 2. Determinanti della salute (Europa)

The Main Determinants of Health

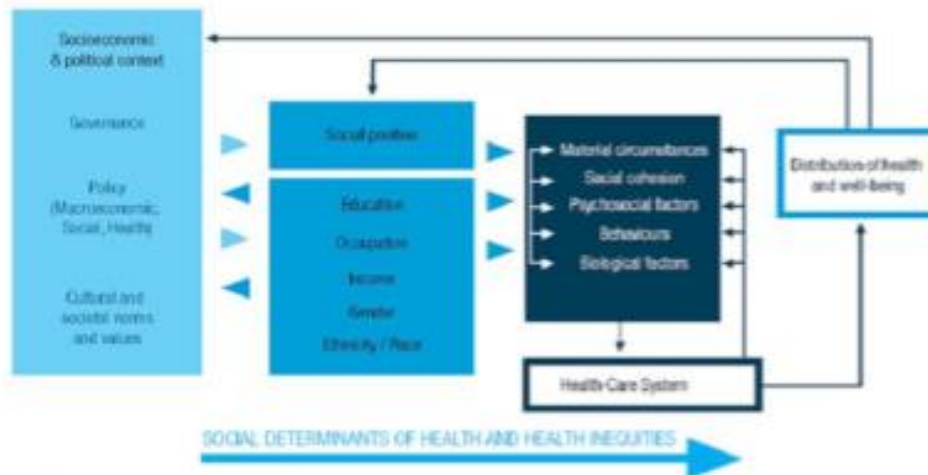


Source: Dahlgren and Whitehead, 1993

- Il secondo modello è espresso in una serie di strati concentrici, corrispondenti ciascuno a differenti livelli di influenza.
- **Al centro c'è l'individuo, con le sue caratteristiche biologiche** (il sesso, l'età, il patrimonio genetico): ovvero i determinanti non modificabili della salute.
- **I determinanti modificabili**, quelli cioè che sono suscettibili di essere corretti e trasformati, **si muovono dagli strati interni verso quelli più esterni: gli stili di vita individuali, le reti sociali e comunitarie, l'ambiente di vita e di lavoro, il contesto politico, sociale, economico e culturale.**
- Tale modello concettuale è molto più complesso e articolato del precedente; **la grafica a semicerchi concentrici rivela una gerarchia di valore tra i diversi determinanti della salute (sono i semicerchi più esterni, quelli che rappresentano il "contesto", a influire maggiormente sullo stato di salute).**

Terzo modello

Slide 3. Determinanti sociali della salute e delle disuguaglianze nella salute



- Modello proposto dalla Commissione sui Determinanti Sociali della Salute.
- Una cornice concettuale che si riferisce non solo ai fattori che influenzano lo stato di salute degli individui e delle comunità (determinanti della salute), ma anche a quelli coinvolti nella diseguale distribuzione della salute all'interno della popolazione (determinanti delle disuguaglianze nella salute).

Leggendo la figura da sinistra a destra si evidenziano i fattori che a diverso titolo hanno un impatto sulla distribuzione della salute e del benessere:

A. **Il contesto politico e socio-economico→**

Il “contesto” include un ampio insieme di aspetti strutturali, culturali e funzionali del sistema sociale di cui è impossibile quantificare l'impatto sulla salute degli individui, ma che tuttavia esercita una potente influenza su come una società distribuisce le risorse tra i suoi membri e di conseguenza sulle opportunità di salute della popolazione. Gli aspetti del “contesto” possono essere riassunti nei seguenti elementi principali:

- a) Governance
- b) Politiche sociali
- c) Politiche macroeconomiche
- d) Valori culturali e sociale

B. La posizione socio-economica – [a + b = determinanti strutturali]→

In ogni società le risorse (denaro, potere, prestigio, conoscenza, etc) sono distribuite in modo ineguale. Questa disuguaglianza si manifesta attraverso un sistema di stratificazione sociale o di gerarchia sociale. Le persone raggiungono differenti posizioni nella gerarchia sociale di una società in relazione ad alcune fondamentali variabili:

- a) Reddito
- b) Istruzione (indicatori caratterizzati da un'associazione "dose-risposta" con la salute: più elevati sono i livelli di reddito e di istruzione più favorevoli sono gli indicatori di salute)
- c) Occupazione
- d) Classe sociale
- e) Genere
- f) Razza/Gruppo etnico

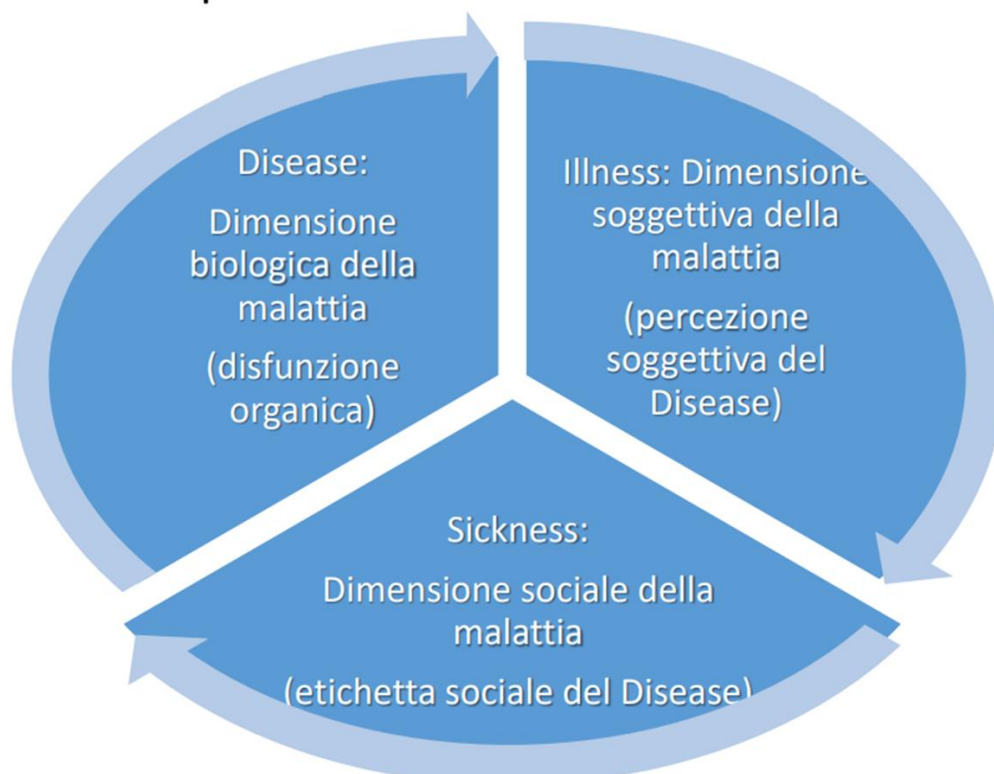
C. Condizioni di vita e di lavoro, fattori psicosociali, coesione sociale, comportamenti individuali e fattori biologici, sistema sanitario – [determinanti intermedi]→

Le principali categorie dei determinanti intermedi di salute sono:

- a) **Condizioni materiali:** gli standard materiali di vita quotidiana (disponibilità di acqua potabile e di cibo adeguato, riscaldamento, infrastrutture igieniche, etc) rappresentano probabilmente il più importante determinante intermedio.
- b) **Condizioni socio-ambientali o psicosociali:** lo stress acuto o cronico può essere causa di diverse forme di malattia; la posizione socio-economica di una persona può essere causa di stress a lungo termine e può influire sulla capacità di quella stessa persona di gestire situazioni stressanti e difficili.
- c) **Comportamenti individuali** come abitudine a fumo, alcol, sostanze, alimentazione, attività fisica, molto condizionati dalla posizione socioeconomica.
- d) **La coesione sociale** che espressa dalla qualità delle relazioni sociali e dall'esistenza di reciproca fiducia e rispetto, di reciproci doveri all'interno della comunità, aiuta a proteggere le persone e la loro salute. Società con alti livelli di disuguaglianze nel reddito tendono ad avere meno coesione sociale e più crimini violenti.
- e) **Fattori biologici non modificabili:** patrimonio genetico, età, sesso.
- f) **Il sistema sanitario.** Il modello concettuale proposto dalla Commissione individua nel sistema sanitario un fondamentale determinante sociale di salute, e di equità nella salute, attraverso alcune principali modalità di azione: intervenendo attraverso la prevenzione primaria nelle aree della nutrizione, dell'igiene ambientale, dell'abitazione e delle condizioni di lavoro; riducendo la vulnerabilità nei confronti delle malattie come le vaccinazioni o il supporto sociale; curando e riabilitando i problemi di salute che costituiscono il gap socioeconomico del carico di malattia (la riabilitazione, in particolare, è spesso trascurata come un potenziale fattore nella riduzione delle disuguaglianze nella salute); proteggendo contro le conseguenze sociali ed economiche della malattia attraverso la copertura assicurativa sanitaria e adeguate politiche del lavoro.

3 COMPONENTI DELLA MALATTIA--> rispecchia il MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE

Le componenti della malattia



- **DISEASE** è la malattia intesa in senso biomedico come lesione organica o aggressione di agenti esterni, evento comunque oggettivabile mediante una serie di parametri organici di natura fisico chimica (temperatura del corpo, alterazioni nella componente sanguigna, ecc.)
- **ILLNESS** costituisce l'esperienza soggettiva dello star male vissuta dal soggetto malato sulla base della sua percezione soggettiva del malessere sempre culturalmente mediata, dal momento che non è possibile alcun accesso diretto cosciente al proprio vissuto corporeo
- Ma il concetto di malattia non si limita soltanto alla componente bio medica (disease) e alla componente soggettiva (illness) ma considera anche la malattia intesa come riconoscimento sociale. Come afferma Michael Bury: «Mentre la malattia ha un carattere estremamente individuale, la sua esperienza prende inevitabilmente caratteristiche sociali, in quanto gli individui interagiscono nel corso del tempo con l'ambiente fisico e sociale». Questa terza dimensione prende il nome di **SICKNESS**.

Il caso classico di malattia è quello in cui una persona si sente male (ill), il medico certifica la sua malattia (disease) e la società gli attribuisce l'etichetta di malato (sick). Possiamo affermare che: l'illness gli permette di dare un senso al proprio malessere, il disease gli permette l'accesso alle cure mediche e la sickness lo libera dalle incombenze lavorative e gli dà diritto, eventualmente, a un aiuto economico.

7 COMBINAZIONI TRA LE TRE COMPONENTI

Situazioni in cui c'è solo una componente, due o tutte e tre le componenti

	Disease (D)	Illness (I)	Sickness (S)
Disease (D)	D	DI	DS
Illness (I)	ID	I	IS
Sickness (S)	SD	SI	S

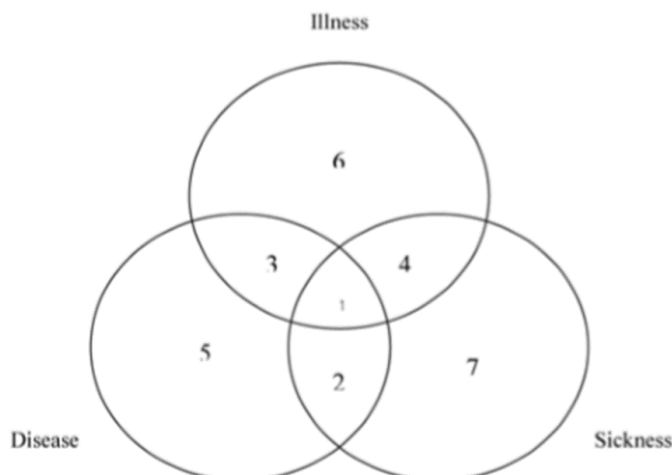
- 1 → DSI es. ernia
- 2 → DS epatite invisibili, non da sintomi, coma
- 3 → DI raffreddore, invecchiamento, mal di mare
- 4 → SI colpo di frusta
- 5 → D es. alcolismo, lieve ipertensione
- 6 → I tristezza, malinconia, innamoramento
- 7 → S omosessualità

D → BIO

I → PSICO

S → SOCIALE

Fig. 1 - La combinatoria DIS [2002: 653]



RAPPRESENTAZIONE DELLA MALATTIA→ insieme delle credenze proprie del pz. riguardo a essa (Leventhal) che costituiscono per il paziente lo schema di riferimento per comprendere la propria malattia a affrontarla.

Le principali dimensioni che costituiscono la rappresentazione individuale di malattia sono

- IDENTITA'
- CAUSA
- DURATA
- CONSEGUENZA
- CONTROLLABILITA' O CURABILITA'

LA RAPPRESENTAZIONE è UN PREDITTORE DI ESITO

di ADATTAMENTO e GESTIONE→ nella malattia cronica

- modalità scelte per affrontare la malattia
- aderenza alle prescrizioni
- intenzione di partecipare ai programmi di riabilitazione
- uso di servizi sanitari

di RECUPERO FUNZIONALE→ nell'evento acuto

VIENE RISPECCHIATA DALL'ADERENZA DEL PZ. PER ESEMPIO ALLA TERAPIA

Grado con il quale il comportamento di un soggetto – assumere un farmaco, seguire una dieta e/o modificare il proprio stile di vita – corrisponde a quanto concordato con l'operatore sanitario.

Paziente attivo

Il termine “persistenza” specifica il mantenimento nel tempo di una terapia.

REAZIONI PSICOLOGICHE ALLA MALATTIA SOMATICA

Malattia è:

- a) Modificazione equilibri precedenti
- b) Situazione di crisi
- c) Cambiamento status del paziente: da sano a malato
- d) Adattamento a situazione nuova con problemi interni ed esterni.

Problemi interni: reazioni psicologiche alla nuova identità.

Problemi esterni: modificazioni dieta, abitudini di vita, lavoro.

I due tipi di problemi si influenzano a vicenda tanto più quanto maggiore è stato il cambiamento.

La **malattia** porta ad una sorta di piccola rivoluzione:

- il pz. si trova a dover «ascoltare» il proprio corpo; chi da sano, ad esempio, ascolta il proprio cuore?
- **La malattia fisica ha conseguenze sul piano psicologico:** senso di debolezza, status negativo...

La reazione psicologica alla malattia somatica influenza:

- il decorso stesso della malattia,
- l'accettazione o meno della terapia,
- i rapporti con medico, familiari, ambiente sociale.

Reazioni emotivo-psicologiche più comuni di fronte alla malattia:

1. Ansia
2. Rabbia e ostilità
3. Dolore e prostrazione
4. Chiusura e ritiro
5. Speranza e fiducia.

La reazione di un soggetto alla malattia varia in base ad alcuni fattori.

Quali?

- **Tipo di organo colpito e grado di investimento di questo:** certi organi (cuore, cervello, organi genitali) hanno un maggior investimento affettivo.
- **Natura e gravità della malattia:** quelle croniche e a rischio sconvolgono di più l'equilibrio psicologico.
- **Modalità di insorgenza e decorso:** più l'esordio è acuto più la malattia rappresenta una minaccia che non si ha tempo di accettare e comprendere.
- **Presenza di dolore associato alla malattia.**
- **Visibilità dell'organo malato.**
- **Eziologia della malattia:** causa ereditaria o legata a comportamenti personali (fumo, malattie a trasmissione sessuale) intaccano l'autostima del pz inducendo sensi di colpa.
- **Considerazione sociale del tipo di malattia e del problema sanitario:** malattie trasmesse sessualmente, malattie mentali o particolari interventi come per IVG hanno una connotazione pubblica diversa da altre.
- **Eventuale ricovero ed esami specialistici:** cambiamento delle abitudini di vita per degenza o attuazione di esami complessi e dolorosi connotano la malattia negativamente.
- **Eventuale intervento chirurgico:** vediamo dopo.
- **Tipo di relazione col medico, il personale e l'istituzione sanitaria:** vi sono elementi interni (psicologici) ed esterni (appuntamento, ricetta, invio per esami o ricovero, ecc.).
- **Reazione dei familiari e dell'ambiente sociale:** problema del "sostegno sociale" importante per reinserimento e riabilitazione.
- **Modificazioni lavorative e delle abitudini di vita**
- **Sfondo sociale, culturale, economico religioso, razziale: esempi di ostacolo all'intervento sanitario:** rifiuto delle trasfusioni per concezioni religiose, rifiuto del malato mentale o la sua emarginazione in una società produttivistica, reticenza a parlare di problemi sessuali in certi ambienti sociali, ecc.
- **Età del soggetto:** in certi periodi di vita si è più vulnerabili e ciò condiziona la reazione alla malattia.
- **Tipo di aspettative personali sul piano sociale e/o relazionale:** ad esempio un intervento di isterectomia per una giovane donna senza figli che ha investito il futuro nella maternità.
- **Tipo di personalità su cui la malattia si inserisce:** molto importante nella reazione alla malattia.

TEORIA DI PAOLO BOERI (2001)

Paolo Boeri (2001) propone una modalità di porsi verso il fattore di crisi che, sia pure nel rispetto delle numerose varianti soggettive, si ritrova rappresentata nella maggior parte dei malati, e che può essere suddivisa in quattro “classiche” fasi:

- fase di *shock*;
- fase di reazione;
- fase di elaborazione;
- fase di riorientamento

E' importante considerare la progressione delle quattro fasi come un processo tutt'altro che lineare e tutt'altro che unidirezionale; inoltre, i "confini" tra una fase e la successiva possono essere molto sfumati, per cui non è sempre agevole riconoscere l'avvenuta entrata nella fase successiva.

FASE DI SHOCK

- La “fase di *shock*” corrisponde al momento della diagnosi ed al periodo immediatamente successivo. Un concetto ricorrente espresso dai pazienti relativamente a quei momenti è "Ho sentito crollarmi il mondo addosso": una espressione che rende efficacemente l'idea della perdita degli abituali punti di riferimento e dello sconvolgimento di ogni schema, sia proprio sia del nucleo familiare di appartenenza.
- Un problema strettamente connesso all'impatto riguarda le modalità di comunicazione della diagnosi usate dal medico. La realtà cui far fronte può in quel momento apparire troppo pesante e cruda: possono entrare in azione meccanismi di difesa inconsci, che assolvono alla fondamentale funzione di mediare l'impatto, di filtrare il dato di realtà in modo da renderlo sostenibile, così che la struttura che sostiene l'attività psichica non corra il rischio di essere sopraffatta dall'angoscia

FASE DI REAZIONE

- Superato lo *shock* dell'impatto della diagnosi, il malato comincia a entrare nel vivo del percorso terapeutico. Egli entra dunque nella “fase di reazione”. È possibile in questa fase nutrire vissuti che dall'incertezza sconfinano nell'angoscia.
- La persona rischia di essere "schiacciata" dall'interno sulla dimensione del presente (esami, accertamenti, pareri medici, storie/racconti di altri malati o ex malati). L'intera vita, per un po', ruota intorno a questi elementi, o quanto meno ne è fortemente condizionata.
- Una espressione caratteristica di tale appiattimento sul presente è l'impossibilità di sviluppare qualunque tipo di progettualità. Il paziente non riesce a proiettare se stesso in alcuna dimensione futura, neanche nel breve termine.

- Si possono manifestare in questa fase sia atteggiamenti di tipo maniacale (ad esempio un paziente che sta molto male che dice "Sto benone"), sia regressioni infantili (con atteggiamenti di dipendenza e "capricci"). Una manifestazione tipica è quella di rabbia. Alla base della rabbia troviamo per lo più un mancato sbocco alla questione del: "Perché tutto questo, e perché proprio a me?". Si tratta di una domanda senza risposta, almeno in questa fase, che il paziente rivolge a se stesso e, a volte, anche a chi gli sta intorno, senza aspettarsi più di tanto di ottenere riscontri credibili. La rabbia che non è più gestibile può anche essere proiettata all'esterno, magari proprio sulle persone più vicine e care, e non di rado sul personale sanitario, accusato di manchevolezze di vario genere e, in sostanza, di "non fare abbastanza".

FASE DI ELABORAZIONE O/E DI RIORIENTAMENTO

- La "fase di elaborazione" è quella che si apre, di solito, al termine della prima fase intensa di esami e trattamenti. Finalmente per il malato c'è la possibilità di cominciare a prendere le distanze da quanto è successo. Il percorso di ricerca di senso può essere intrapreso senza affanno e con un minore carico di rabbia. Rimangono, assai vivide, la paura e l'incertezza, ma si aprono spazi per potersi fermare a pensare, per una riflessione sulla vita condotta fino a quel momento, sulle scelte del passato, su quel che rimane da fare.
- Se l'operazione riesce, si apre la fase di "riorientamento": le coordinate sono ritrovate, la rotta può essere ripresa, è anche possibile scorgere ampi squarci di sereno. È stato trovato un senso alla malattia. Si può perfino riprovare a costruire un futuro praticabile per sé, e calarsi in modo credibile in questa dimensione ritrovata.

TEORIA DI KUBLER ROSS (1970)

Kubler Ross (1970), nella sua teoria degli stadi del morire, individua le principali reazioni alla malattia:

- **RIFIUTO E ISOLAMENTO** → è lo stato di *shock* che si osserva al momento della comunicazione della diagnosi;
- **COLLERA E RABBIA** → il malato si chiede perché proprio a me, perché non ad un altro; si osservano atteggiamenti di invidia, risentimento ed ostilità generalizzata contro tutto e contro tutti;
- **COMPROMESSO E PATTEGGIAMENTO** → il paziente si chiede "Perché proprio ora" e pensa "Se Dio ha deciso di togliermi da questo mondo e non risponde alle mie preghiere starò meglio se gli offro qualche cosa in cambio"; oppure "Mi comporterò in tal modo, allora potrò anche guarire." L'ammalato tende a spostare nel tempo il momento del peggioramento della malattia attraverso una serie di

compromessi (“studierò di più”, “non andrò a ballare per sei mesi”, “non chiederò la patente”);

- **DEPRESSIONE**→ si può manifestare sotto forma reattiva o preparatoria. La prima è legata a tutto un mondo di cose ed affetti che si è costretti a lasciare; la seconda accompagna l'ammalato quando inizia a separarsi dal mondo;
- **ACCETTAZIONE**→ avviene prevalentemente nella fase terminale. Questo momento è registrato come un vuoto di sentimenti e come se la lotta fosse finita per lasciare il posto alla consapevolezza rassegnata della morte.

Ospedalizzazione→ Cambiamento di vita, dipendenza da parte del paziente e rapporti regressivi.

Durante l'ospedalizzazione:

1) **Il pz perde l'autonomia decisionale**: vi sono le regole dell'ospedale, non è nemmeno padrone del proprio corpo (occhi dei medici, infermieri, studenti).

2) **Il pz si riaffida alla gestione di altri**: autorità paterna del medico che decide i compiti e le regole, le cure materne dell'infermiere che osserva e controlla le funzioni più semplici (mangiare, defecare e urinare, temperatura del corpo).

Meccanismi di difesa messi in atto in caso di malattia

L'insorgenza di una malattia influenza significativamente tutte le dimensioni di vita del paziente attivando dinamiche difensive, sia nel **malato** che nei **familiari**, quali conseguenze del disagio e del conflitto psichico sorti in seguito all'impossibilità immediata di soddisfare il bisogno di benessere e salute.

I MdD possono essere attivati anche nell'**operatore sanitario**, il quale, per tutelarsi dalle tensioni critiche specifiche del rapporto con il pz e la sua famiglia e le richieste dell'organizzazione sanitaria, può riequilibrare le sue condizioni di disagio attraverso difese specifiche.

La formazione reattiva

- Questa difesa consiste nel tenere lontano un desiderio o impulso inaccettabile adottando un tratto di carattere di tipo diametralmente opposto (Gabbard, 2007).
- La frustrazione che consegue una diagnosi di malattia, l'incapacità di tollerare l'angoscia, possono portare il paziente a essere reattivo verso le persone vicine (familiari, operatori, altri pazienti).
- Si può assistere anche a un eccesso di altruismo che induce il paziente a occuparsi invasivamente e intrusivamente delle necessità degli altri pazienti, generalizzando come modello di riferimento le proprie esperienze e conoscenze (De Carlo, Faa & Rutelli, 2008).

L'isolamento dell'affetto

- Questo meccanismo separa l'affetto dall'ideazione. L'aspetto affettivo di un'esperienza o di un'idea viene separato dalla sua dimensione cognitiva (Mc Williams, 1999).
- Le persone che utilizzano questa modalità difensiva raccontano i propri vissuti con distacco emotivo riferendo di non provare sentimenti rilevanti in situazioni in cui tutti ne provano la presenza. È il caso del paziente che non riuscendo a tollerare la tensione emotiva del proprio vissuto di malattia ne scinde la componente emozionale da quella razionale incrementando la richiesta di informazioni tecniche e cliniche come alimento sedativo delle proprie ansie e angosce.

La negazione

- Modalità per cui i contenuti rimossi possono accedere alla coscienza alla sola condizione di essere negati. E' una variante meno grave del diniego in cui vi è una completa scotomizzazione del dato di fatto conflittuale, senza alcuna consapevolezza di ciò. Nella negazione quello che viene negato è solo l'affetto, mentre il rapporto con la realtà è di norma mantenuto (Galimberti, 1999).
- Questo meccanismo è molto frequente in campo sanitario, nei pazienti porta ad un rifiuto della malattia e della sua gravità. La negazione della diagnosi e/o della terapia possono però avere conseguenze gravi quali ad esempio il rifiuto di fare controlli medici e diagnostici, di sottoporsi alle terapie, di seguire le prescrizioni medico-sanitarie andando quindi ad influire negativamente sull'*adherence*

Può essere:

- a) **Completa:** negazione della malattia stessa, il pz si comporta come se non avesse disturbi. Es: pz che non si attiene a prescrizioni terapeutiche e norme di condotta indispensabili o sviluppa iperattività.
- b) **Parziale:** pz riconosce di essere malato, ma non accetta la verità sulla malattia da cui è affetto, es: hanno il cancro e pensano di avere una cisti.

Altro modo di negare la malattia: sopravvalutare il medico e le sue possibilità di intervento.

La proiezione

- Processo per cui qualcosa di interno viene considerato proveniente dall'esterno. Meccanismo inconscio rappresentato dall'attribuzione ad altre persone di pensieri, emozioni o sentimenti, che invece appartengono a sé (Mc Williams, 1999).
- Molto frequente è la sua comparsa in ambito sanitario laddove il paziente attribuisce contenuti dei propri pensieri ed emozioni inaccettabili ad altri.
- Proiettare su altri inconsapevolmente significa liberarsi di un fardello inaccettabile. Il medico è sfuggente, non disponibile e solidale: sono valutazioni proiettive che attribuiscono nuclei di aggressività in realtà vissuti contro ma proiettati sull'altro.

La regressione

- È un meccanismo di difesa tramite il quale un individuo ritorna (regredisce), sotto la spinta di istanze inconse, a fasi antecedenti del suo sviluppo psicologico.
- Durante la malattia compare sotto forma di processi di dipendenza, dove il paziente assume la posizione psicologica del bambino dipendente che si attende dal medico, dall'operatore o dai familiari risposte di protezione e difesa dai rischi indotti dalla malattia.
- Dipendere significa rinunciare a parte della propria autonomia ma anche godere del vantaggio secondario della non assunzione di responsabilità.

La rimozione

- Essa opera inconsciamente eliminando dalla consapevolezza desideri, fantasie o sentimenti inaccettabili (Gabbard, 2007).
- La sua rappresentazione in ambito sanitario si verifica quando il paziente, pur essendo stato informato adeguatamente sugli esiti diagnostici, sui processi terapeutici, sulle opportunità, rimuove alcuni dati a lui forniti perché vissuti come inaccettabili. Negare l'informazione ricevuta è come negare il problema, negare il problema è negare il disagio e l'ansia conseguente.

Lo spostamento

- Processo inconscio in virtù del quale pulsioni, emozioni, preoccupazioni o comportamenti relativi a un dato oggetto/persona vengono reindirizzati verso un altro oggetto, poiché la direzione originaria per qualche ragione provoca ansia (Mc Williams, 1999).
- Il paziente preferisce inconsapevolmente sostituire un contenuto con un altro, una causa con un'altra, un effetto con un altro. Ne saranno investite le sue aspettative dove per evitare una diagnosi continuerà a ripetere le analisi o per non definirne l'esito diagnostico sposterà aspettative da un medico a un altro, procrastinando, attraverso lo spostamento, l'esito finale di una diagnosi o di una decisione.
- Anche se funzionale è importante che la persona, in seguito alla fase acuta, superi tale passività-dipendenza in quanto potrebbe essere di impedimento del percorso di raggiungimento di autonomia e benessere.

Le reazioni psicologiche allo stato di malattia vanno:

- **RISPETTATE** → se sono utili all'equilibrio del pz e permettono di sopportare;
- **OSTACOLATE** → se impediscono l'attuazione di decisioni importanti per la salute.

Vale soprattutto di fronte a malattie gravi e mortali in cui pz e sanitario si confrontano con l'idea della morte

Condizioni: centro tumori in cui ci si chiede: "dire o no la verità?".

Il silenzio e le risposte poco chiare sono fonte di angoscia, ma a volte il pz non tollera la realtà.

A tal proposito vale: "dare ad ognuno la verità che è in grado di tollerare".

In conclusione

- Le difese vanno individuate e capite.
- Solo dopo averle lette all'interno della struttura del soggetto in cui possono essere funzionali o no, si può decidere di rinforzarle o limitarle

Reazioni e strategie funzionali e adattive.

COPING

La malattia è sempre una fonte di stress e l'ansia favorisce comportamenti più o meno adattivi per far fronte alla situazione.

Le reazioni e le strategie messe in atto per far fronte allo stress variano in base al temperamento, alle esperienze passate, allo stato fisico; sono cioè i fattori interagenti a determinare le modalità di reagire allo stress, che vengono denominate con il termine ***coping***.

COPING → l'insieme degli sforzi cognitivi e comportamentali per far fronte a specifiche esigenze, esterne ed interne, che sono vissute come imposizioni o come superiori alle risorse del soggetto.

Le strategie di *coping* si dividono in

- **“centrate sul problema”** → ha come elemento fondamentale l'azione ed è mirato a modificare il rapporto persona-ambiente mediante atti strumentali (fare, agire),
- **“centrate sulle emozioni”** → ha come fondamento le strategie cognitive, che mirano ad attribuire un determinato significato alle situazioni vissute (Lazarus & Folkman, 1984).

Gli studi hanno dimostrato che **le strategie di coping dirette all'accettazione della malattia sono associate a un migliore funzionamento generale**, rispetto a strategie dirette all'evitamento o al disimpegno mentale/comportamentale dai problemi.

Queste ultime sono legate a: peggiore salute fisica, adattamento psicologico più scadente e aumento del disagio psicologico (Murphy et al., 1999).

RESILIENZA

Il concetto di resilienza (dal latino “*resilire*”: rimbalzare e tornare indietro con un salto) è mutuato dalla fisica dei materiali ed indica la capacità, propria di alcuni metalli, di resistere ad un urto senza spezzarsi.

In psicologia, il concetto di resilienza può essere definito come **la capacità umana universale di affrontare, superare e addirittura uscire rinforzati da esperienze negative** (Grotberg, 1995).

La resilienza non corrisponde semplicemente alla capacità di resistere alle difficoltà proteggendo il proprio io da circostanze problematiche, ma rappresenta, altresì, una **possibilità di reagire positivamente a scapito delle difficoltà favorendo la costruzione di percorsi positivi utilizzando la forza interiore propria degli esseri umani** (Manetti et al., 2004).

Come si evince da queste definizioni, la resilienza indica un aspetto fondamentale per tutti gli esseri umani: **la capacità di fronteggiare situazioni di crisi attivando energie e risorse al fine di proseguire lungo una traiettoria di crescita.**

Vi sono poi alcune variabili psicologiche che risultano associate al processo di resilienza:

- **L'adattamento**→ abilità di far fronte alle richieste dell'ambiente attivando risposte adattive
- **l'autoefficacia**→ convinzione di poter modificare la propria esperienza attraverso il controllo efficace sull'ambiente circostante)
- **il locus of control**→ processo di attribuzione secondo cui la spiegazione di eventi positivi o negativi viene ricondotta a variabili relative al sé, su cui la persona può esercitare un controllo attivo, oppure a variabili relative ad altri, alle circostanze o al fato, comunque non soggette al controllo personale)
- **la resistenza allo stress**→ capacità di far fronte a pressioni ambientali eccessive

Malattia e Crescita Post-Traumatica

Già in antichità la filosofia e la religione hanno riconosciuto il **potenziale impatto positivo di eventi dolorosi sulla vita delle persone, rendendole più sagge e protagoniste di cambiamenti di vita positivi, tramutando il trauma in crescita.**

Possibilità di una persona di vivere, dopo un evento traumatico, trasformazioni positive in particolare in 3 aree specifiche:

- **percezione di sé** → idea di non sentirsi più “vittime”, ma persone che hanno superato un evento difficile, **aumentando quindi la fiducia in se stesse**, ma allo stesso tempo **riconoscendo la vulnerabilità della natura umana**
- **relazioni interpersonali** → sentire più intensamente la vicinanza affettiva delle persone significative, riscoprendo vecchie e nuove relazioni e ponendo fine a quelle meno importanti e sincere, in una nuova e più empatica visione delle relazioni interpersonali
- **filosofia di vita** → il cambiamento positivo può riguardare il concetto stesso di vita e il suo significato; molto spesso infatti le persone che hanno sentito minacciata la propria vita riescono poi ad apprezzarla in maniera più piena e intensa godendone ogni singolo momento e rivedendone le priorità.

Il paziente chirurgico

- Psicologia del paziente chirurgico
- Il chirurgo
- L'ansia preoperatoria
- Fattori di rischio per ansia preoperatoria
- La perdita di organi
- Immagine corporea
- L'anestesia
- Il decorso postoperatorio

PSICOLOGIA DEL PAZIENTE CHIRURGICO

La maggior parte dei pazienti dice di aver “terrore” della chirurgia, anche se esistono notevoli differenze nella risposta che danno allo stress chirurgico e nelle strategie che mettono in atto.

I pazienti candidati a un intervento chirurgico sono accomunati da alcune **paure come:**

- la morte,
- il timore di perdere il controllo sul proprio corpo (durante l'anestesia),
- la paura dell'anestesia stessa e delle possibili conseguenze negative dell'intervento stesso,
- la paura del dolore postoperatorio

IL RUOLO DELL'INFORMAZIONE

E' innegabile l'influenza di fattori individuali riguardo alle paure e al decorso postoperatorio:

- capacità cognitive del paziente,
- livello d'ansia,
- Età
- variabili psicosociali dello stesso

Un altro parametro da considerare è la corretta informazione data al paziente nel periodo preoperatorio.

È determinante informare “step by step” il paziente su ciò che gli verrà fatto. Queste informazioni riguarderanno:

- le visite specialistiche che egli dovrà affrontare (del chirurgo e dell'anestesista),
- l'importanza del digiuno dalla mezzanotte (per evitare la polmonite ab ingestis) e del riposo la notte prima dell'intervento (è fondamentale affrontare l'intervento per riposati)
- la spiegazione riguardo le possibili trasfusioni (tranquillizzandolo riguardo alla trasmissione di infezioni emoguidate e alla possibilità di autodonazione),
- delucidazioni riguardo la tricotomia (che serve a diminuire il rischio di infezioni dato dalla cute, sede abituale di batteri)
- l'utilizzo degli antidolorifici nel postoperatorio.

Si è notato che una corretta informazione riguardo a tutti questi aspetti influisce positivamente sul decorso postoperatorio soprattutto in termini di riduzione del tempo di degenza ospedaliera e dell'uso di analgesici.

È possibile ridurre l'intensità delle paure e modificare in senso positivo il decorso postoperatorio.

IL CHIRURGO

Il rapporto tra il paziente candidato all'intervento chirurgico e il chirurgo stesso è un rapporto particolare.

Da un lato c'è lo specialista che si ritrova a essere, suo malgrado, "padrone" della vita e della morte del paziente, dall'altro c'è il paziente che si mette totalmente nelle sue mani.

Nell'alleanza chirurgo/paziente, il chirurgo offre il suo acume clinico, le conoscenze scientifiche e le abilità tecniche "in cambio" della totale disponibilità del paziente a farsi curare da lui, accettando tutti i rischi insiti nell'atto chirurgico stesso.

Sia al medico sia al paziente deve però essere chiaro che, in questa alleanza non è tutto perfetto.

Il paziente deve saper accettare che ogni azione umana, atto chirurgico incluso, contiene elementi di imponderabilità con conseguente possibilità di errore.

Così come il chirurgo deve saper accettare il fatto che il suo intervento può non aver successo: la malattia può non essere debellata.

IL CHIRURGO E L'ANSIA

Il chirurgo è caricato di angosce e responsabilità; egli si confronta quotidianamente con dolore, mutilazione e morte. Quotidianamente si trova ad affrontare le sue ansie, dominandole per fronteggiare l'ansia stessa dei pazienti e dei loro familiari.

L'attività di sala operatoria è estremamente estenuante, dal punto di vista psicologico e fisico. Nell'urgenza chirurgica, lo stress che il chirurgo deve affrontare è ancora maggiore: la gravità del caso impone una rapidità, una sicurezza e un bagaglio tecnico che già di per se stessi comportano per il chirurgo una condizione ansiogena.

Ma il chirurgo non può permettersi di far trasparire la sua ansia, seppur giustificata e legittima, in quanto rischierebbe di contagiare con questo atteggiamento l'equipe di sala.

IL CHIRURGO, RELAZIONE E COMUNICAZIONE

Pertanto, è ovvio che il chirurgo può avere un approccio psicologico al malato molto diverso da quello degli altri medici specialisti; **il suo rapporto con il paziente è asimmetrico, in quanto il secondo è parte passiva nelle mani del primo che ha viceversa ruolo attivo.**

Come ricorda Schneider (1969), **il chirurgo non può e non deve identificarsi con la malato perché se lo facesse gli sarebbe molto difficile esercitare al meglio il compito che è chiamato a fare e cioè operarlo. Non può lasciarsi influenzare dall'emotività ma deve sempre saper dominare le sue emozioni e sapersi distaccare da tutto ciò che lo circonda, per eseguire con esattezza, prontezza e essenzialità l'atto chirurgico.**

Il chirurgo finisce con l'indossare una sorta di armatura per avere quel distanziamento dal paziente che lo protegge dalla propria vulnerabilità emotiva.

Questa armatura si evidenzia anche nella freddezza e concisione con la quale fornisce le informazioni ai familiari del malato e nella comunicazione di situazioni emotivamente complesse quali il decesso del paziente ai familiari.

ANSIA PREOPERATORIA

I pazienti che si devono sottoporre a interventi chirurgici, nella maggior parte dei casi, provano un acuto **distress psicologico nel periodo preoperatorio**

Questo è dovuto a fattori presenti in generale in tutti i ricoveri:

- angoscia di malattia,
- estromissione dal proprio contesto di riferimento,
- difficoltà rapporto con altri ricoverati e con il personale,
- dolore fisico
- Specifico timore dell'operazione che per il paziente chirurgico assume un carattere di ambivalenza tra:
 - Atto desiderato come risolutorio e guaritore
 - Atto paventato come portatore di ulteriore sofferenza

L'anestesia costituisce uno degli aspetti più importanti e preoccupanti per il paziente chirurgico

Lo stato ansioso nel preoperatorio può produrre **reazioni aggressive** che possono:

- Causare un aumento del distress
- Causare un peggioramento della qualità di vita
- Rendere la gestione e il controllo del dolore postoperatorio più difficoltosi
- Richiedere dosi più elevati di anestetico durante l'intervento e di analgesici nel postoperatorio
- Ridurre la capacità di prendere adeguate decisioni rispetto alla terapia
- Ridurre l'aderenza alla terapia
- Determinare una minore soddisfazione per il trattamento eseguito

FATTORI DI RISCHIO PER L'ANSIA PREOPERATORIA

I fattori di rischio relativi all'ansia preoperatoria meritano un'accurata e attenta valutazione anche da parte del personale infermieristico

La loro corretta individuazione può essere di aiuto per decidere quali pazienti potrebbero beneficiare di interventi preventivi durante il periodo preoperatorio e per pianificare specifici interventi mirati sugli specifici fattori, in modo da poter rendere questo periodo meno stressante e più sicuro

- **Disordini psichiatrici minori** sono spesso associati con ansia preoperatoria. È importante ricordarlo poiché questi disordini affliggono un'alta percentuale di pazienti e che spesso non sono diagnosticati
- **Percezione negativa del futuro**
- Numerosi studi hanno riportato una maggiore prevalenza di **depressione** nei pazienti chirurgici. Sintomi depressivi sono associati a più elevati livelli di dolore postoperatorio, a una più elevata mortalità e a una convalescenza più lunga. Inoltre possono produrre una diminuzione transitoria delle difese immunitarie che potrebbe causare un aumento del rischio di complicanze.
- È stata rilevata anche una forte associazione tra la presenza di ansia preoperatoria (ansia di stato) ed elevati livelli di **ansia di tratto** (collegata cioè alla personalità del paziente).
- Presenza di **dolore** intenso o moderato
- **Tipologia di intervento**: gli interventi che causano maggiormente ansia sono quelli associati a mutilazioni (es. isterectomie, mastectomie...)
- I **fumatori** presentano un rischio più alto di poter sviluppare uno stato ansioso prima dell'intervento: astinenza
- Aver già subito **altri interventi chirurgici** riduce invece il rischio di ansia preoperatoria, in relazione al fatto che il paziente potrebbe aver già imparato a gestire gli stimoli ansiogeni che si presentano durante il ricovero; cruciale è comunque la qualità dell'esperienza precedentemente avuta.
- Le **caratteristiche demografiche** associate all'ansia sono il sesso (sesso femminile presenta un più elevato rischio) e la scolarità (alto)
- La possibilità di sottoporsi a un intervento in regime di **day surgery** cioè senza la necessità di ospedalizzazione è un fattore protettivo: il pensiero che tutto finirà in un giorno e che la notte potrà essere trascorsa nel proprio letto rende la prospettiva dell'intervento più tollerabile.
- È stata evidenziata infine anche una forte associazione tra la presenza di ansia preoperatoria e una peggiore **valutazione anestesiológica**

Valutazione del rischio di distress acuto e dei meccanismi di difesa → Relazione/alleanza terapeutica-educativa → Adattamento positivo ed efficace allo stress chirurgico

LA PERDITA DEGLI ORGANI→ Fantasie connesse alla perdita di organi: si iscrivono nel complesso simbolismo legato all'organo asportato o alla parte amputata e coinvolgono l'investimento libidico relativo a quell'organo e a quella parte, nonché la modificazione dell'immagine corporea. Importante descrivere in che cosa consisterà la perdita dell'organo e come potrà essere compensata, sia da un punto di vista fisiologico che psicologico.

IMMAGINE CORPOREA→ Schema neuropsicologico o quadro mentale che ci facciamo del nostro corpo. Insieme delle percezioni, affetti e idee che, attraverso la sua storia personale e gli atteggiamenti della collettività, un individuo attribuisce al suo corpo.

Le reazioni psicologiche sono scatenate dal conflitto interno scaturito dall'incongruenza tra l'immagine corporea interiore ed una immagine corporea esteriore (acquisita in seguito all'intervento) nella quale il paziente non si identifica

L'asportazione di organi (esterni ma anche interni) può comportare sia una perturbazione di questo schema mentale, sia la ricostruzione di un inconsueto schema in cui una nuova e diversa struttura dovrà vicariare le funzioni della parte asportata.

La minaccia per la perdita di un organo può anche provocare una reazione di lutto anticipatorio: il malato inconsciamente identifica la parte con il tutto ed è come se, perdendo quell'organo, egli vivesse la perdita di una persona molto vicina, come avviene nel lutto

IL DECORSO POST-OPERATORIO→ La preparazione psicologica e le informazioni fornite al paziente prima dell'intervento possono condizionare anche il decorso postoperatorio.

Soggetti che non hanno ricevuto sufficienti informazioni prima dell'intervento presentano un decorso PO più lungo e complicato.

Al contrario, i pazienti che hanno ricevuto informazioni adeguate e hanno potuto instaurare un rapporto di fiducia con il personale ospedaliero provano meno ansia, meno dolore e di conseguenza fanno meno uso di analgesici, soprattutto se la natura delle informazioni è stata adattata al tipo di personalità del paziente e se la comunicazione è stata fatta al momento opportuno.

Il dolore postoperatorio dipende molto dall'ansia preoperatoria e dallo stile di coping del paziente.

È necessario che vengano rafforzati i vissuti positivi del malato, spesso deboli e legati a eventi quali visite di parenti o constatazione di segni tangibili di miglioramento. Sono necessari per prevenire ansia, sentimenti di tristezza e abbandono.

È importante rafforzare la percezione di una continuità di cure nel PO, anche se non ci sono complicanze, curando particolarmente il momento della visita in corsia per poter dare continuità alla relazione terapeutica.

VISSUTI PSICOLOGICI IN BASE AL TIPO DI INTERVENTO CHIRURGICO

VISSUTO PSICOLOGICO DEL PAZIENTE SOTTOPOSTO A RIVASCOLARIZZAZIONE ED AMPUTAZIONE

La reazione del paziente all'amputazione può variare a seconda del contesto:

- **Amputazione da trauma accidentale** (traumi/incidenti, ustioni, cadute, ecc.)
- **Amputazione programmata** come intervento chirurgico parte del trattamento di malattie croniche o patologie antecedenti

Tendenzialmente se il paziente ha tempo per pensare alla perdita imminente può sperimentare le fasi classiche del dolore da "perdita"

1. Fase di ospedalizzazione

Il rapporto équipe curante/paziente e familiari

Il professionista non è immune dal contatto con l'emotività del paziente traumatizzato. L'amputazione costituisce sempre un evento carico di profonda sofferenza per il paziente, i suoi familiari e per il personale sanitario cui è chiesto di "riparare" il danno. Il paziente porta all'équipe curante una domanda di guarigione intrisa di aspettative irrealistiche.

Il rapporto chirurgo/paziente e familiari

Il chirurgo, in particolare, si trova nella situazione di dover informare il paziente sulle prospettive realizzabili.

Paziente	Chirurgo
Atteggiamento di impotenza e rassegnazione	Infondere speranza e ottimismo
Aspettative "miracolistiche"	Vissuti di frustrazione



informare su prospettive realizzabili

2. FASE POST-OPERATORIA → Varia da poche ore-giorni a molti giorni in base alle condizioni dell'arto e all'esito dell'intervento

- Fase di "ottundimento" → anche conseguente all'anestesia
- Fasciatura che protegge e nasconde lasciando spazio a illusioni e fantasie
- Nell'immediato post-operatorio, l'incidenza di arto fantasma si stima coinvolga oltre il 50% dei pazienti che hanno appena finito gli effetti dell'anestesia
- Dolore post-operatorio → peggiora con la mobilizzazione dell'arto o se la ferita chirurgica subisce una pressione; scompare con la guarigione della ferita chirurgica
- Possibile comparsa di sintomatologia di un Disturbo Acuto da Stress (ASD) entro da due giorni a 4 settimane del trauma

3. FASE RIABILITATIVA INTRA-OSPEDALIERA

Il primo contatto con il moncone avviene in molti casi con la cicatrizzazione e l'avvio del protocollo fisioterapeutico.

- Avvio fase rielaborativa vera e propria con la prima elaborazione della perdita
- Dolore del moncone in coincidenza della ferita chirurgica
- Se presente Disturbo Acuto da Stress (20-22% di coloro che hanno subito un incidente e meno del 5% per amputazione da patologia cronica)

4. FASE DIMISSIONE DEL PAZIENTE

Il paziente si confronta con l'ambiente di vita quotidiano, in molti casi con la progettazione della protesi, ed espleta la fase riabilitativa extra-ospedaliera.

VISSUTI PSICOLOGICI DEL PAZIENTE – DISTURBI D'ANSIA

1. DISTURBO ACUTO DA STRESS

- Ansia, sintomi dissociativi e di altro tipo, che si manifestano entro 1 mese dall'esposizione ad un evento traumatico estremo
- Sensazione soggettiva di insensibilità, distacco o assenza di reattività emozionale; riduzione della consapevolezza dell'ambiente; derealizzazione; depersonalizzazione o amnesia dissociativa
- Evitamento marcato degli stimoli che possono evocare ricordi del trauma
- Sintomi marcati di ansia o di aumentato arousal
- I sintomi devono causare disagio clinicamente significativo, interferire significativamente con il normale funzionamento
- Il disturbo dura almeno due giorni e non persiste oltre 4 settimane dopo l'evento traumatico

2. DISTURBO POST-TRAUMATICO DA STRESS

- ❖ Paura intensa, il sentirsi inerme o il provare orrore
- ❖ Il continuo rivivere l'evento traumatico
- ❖ L'evitamento persistente degli stimoli associati con il trauma
- ❖ L'ottundimento della reattività generale
- ❖ Sintomi costanti di aumento dell'arousal
- ❖ Quadro sintomatologico completo presente per più di 1 mese che causa un disagio clinicamente significativo e/ o la menomazione del funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti

VISSUTI PSICOLOGICI DEL PAZIENTE ED ELABORAZIONE DEL DOLORE

L'evento amputazione comporta un'alterazione.

Scema corporeo (body schema) → rappresentazione delle caratteristiche spaziali del proprio corpo che l'individuo ricava a partire dalle informazioni provenienti dagli organi di senso.

Tale rappresentazione cognitiva della posizione e dell'estensione del corpo nello spazio è finalizzata principalmente all'organizzazione dell'azione → SINDROME DELL'ARTO FANTASMA → ***“La Sindrome dell'Arto Fantasma consiste nel persistere della sensazione motoria o sensoriale della presenza di un arto dopo la sua amputazione”.***

È uno di quei fenomeni psicologici che meglio esprimono la differenza fra fisicità del corpo e la rappresentazione psicologica e soggettiva che abbiamo di esso.

Alterazioni immagine corporea (“body image”) → insieme delle percezioni, affetti e idee che, attraverso la sua storia personale e gli atteggiamenti della collettività, un individuo attribuisce al suo corpo.

Conflitto immagine interiore rimasta immutata ed immagine esteriore caratterizzata da una perdita di una parte del Sé:

- Sentirsi sfigurati
- Il moncone diventa come prima cosa che gli altri vedono e da cui viene giudicata l'intera fisicità
- Sentimenti di vergogna e necessità di nascondere la menomazione

GLI STADI DEL DOLORE DA PERDITA

- ✓ ***Negazione/ rifiuto*** → si può manifestare come rifiuto ad impegnarsi nelle conversazioni o nel richiedere le informazioni necessarie in merito alla procedura prevista. Difficoltà a dare informazioni sulla procedura chirurgica e a svolgere il processo di consenso informato
- ✓ ***Rabbia*** → che può essere diretta al team medico, con espressioni di essere “truffati” o “ingannati” rispetto all'accordo dell'amputazione
- ✓ ***Contrattazione*** → tentativo di evitare l'intervento o di ritardarlo per una miriade di ragioni come “sono troppo stanco”, “non voglio andare avanti”)
- ✓ ***Depressione*** → sotto forma di “impotenza appresa” e di sopraffazione

- ✓ **Accettazione** → la quale non può essere raggiunta finché il paziente non è impegnato nel processo di riabilitazione.
Ad esempio → soluzione “salutare” e sacrificio sul piano “estetico” in nome di un miglioramento sul piano di salute

CRITICITA'

Funzionalità arti superiori:

- ❖ Cambiamento della gestualità propria della comunicazione non verbale
- ❖ Attacco all'autonomia (le mani accedono a tutti i distretti corporei per la cura e l'igiene personale)
- ❖ Adattamento rispetto alla sfera sociale e professionale (mani e destrezza digitale come strumenti → tema dell'invalidità)

Funzionalità arti inferiori:

- ❖ Attacco all'autonomia (possibilità di libero spostamento nel proprio spazio vitale → disabilità e barriere architettoniche)
- ❖ Adattamento rispetto alla sfera sociale e professionale (→ tema dell'invalidità)

LA PRESA IN CARICO

Per il benessere del paziente, un trattamento efficace non dovrebbe mai prescindere dall'adottare un'ottica bio-psico-sociale (Engel, 1980) che consideri:

- ✓ Fattori biologici
- ✓ Fattori psicologici (personalità, risorse, stile cognitive...)
- ✓ Fattori sociali (sostegno familiare e sociale, status socioeconomici...)

Tali fattori contribuiscono, grazie ad interazioni reciproche, al benessere fisico e psichico.

VISSUTO PSICOLOGICO DEL PAZIENTE OBESO **SOTTOPOSTO A CHIRURGIA BARIATRICA**

OBESITA' → L'obesità può essere definita come una condizione medica caratterizzata da eccessivo accumulo di grasso corporeo, che può portare effetti sulla salute, sulla qualità di vita e una riduzione dell'aspettativa di vita.

Viene definito obeso un soggetto con un BMI (indice di massa corporea) uguale o maggiore di 30.

L'obesità è una malattia multifattoriale che riconosce nella sua eziologia la copresenza di fattori genetici, metabolici, ormonali, psichici e sociali.

Tra le cause quindi troviamo:

- dieta caratterizzata da eccessivo apporto calorico
- stile di vita sedentario
- scarsa attività fisica
- genetica
- condizioni mediche
- assunzione di farmaci
- malattia psichiatriche.

Da un punto di vista psicologico l'obesità può essere considerata una forma di **DIPENDENZA**.

L'assunzione di cibo risulta essere la soluzione adottata per far fronte a fattori stressanti intrapsichici, familiari e ambientali. Il cibo diventa quindi una forma di compensazione a fronte di stati d'animo ansiosi o depressivi o comunque più in generale di disagio psicologico. In tale ottica l'accumulo di massa grassa può essere inteso come una forma di ritenzione emotiva: le emozioni non vengono mentalizzate, esperite come tali e fronteggiate.

PROBLEMA DI SALUTE PUBBLICA

L'obesità è in allarmante aumento in tutto il mondo, tanto da assumere i caratteri di un'epidemia globale (globesity). In Europa la prevalenza dell'obesità è aumentata di tre volte nelle ultime due decadi, anche in Italia l'obesità rappresenta un problema sanitario di crescente e pressante gravità.

I costi sanitari dell'obesità e del sovrappeso sono, ormai, molto elevati anche a causa dell'incremento della morbidità associata e della mortalità.

Vi sono, infatti, una serie di malattie per le quali è stato dimostrato uno stretto rapporto con l'obesità quali:

- diabete mellito di tipo II
- l'ipercolesterolemia
- l'ipertrigliceridemia
- l'ipertensione arteriosa
- trombosi.

Abbiamo, di fronte a questa grave e preoccupante emergenza, due assolute priorità:

- la prevenzione, con la diffusione di nuove abitudini alimentari e di un corretto stile di vita
- la cura efficace e duratura dei casi esistenti, soprattutto quelli più gravi.

CHIRURGIA BARIATRICA

Bisogna sottolineare come la terapia chirurgica sia l'unica forma di trattamento che consenta la guarigione duratura ed in un elevatissimo numero di casi degli obesi gravi e dei superobesi.

Tale approccio consente un notevole e duraturo calo ponderale indotto dalla chirurgia, una notevole riduzione della morbilità e della mortalità proprie dell'obesità e delle malattie correlate, un notevole miglioramento della qualità della vita e con una notevole riduzione dei costi diretti per la Sanità. Vi sarebbe, inoltre, da considerare, e non secondariamente, la notevole riduzione dei costi indiretti, grazie al recupero da parte dei pazienti di una normale attività lavorativa, sociale e di relazione.

Le linee guida riportano come indicazioni all'intervento di chirurgia bariatrica l'avere un B.M.I. ≥ 40 oppure un B.M.I. tra 35 e 40 in presenza di comorbidità che, presumibilmente, possono migliorare o guarire a seguito della notevole e persistente perdita di peso ottenuta con l'intervento.

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE E DI PRESA IN CARICO INTEGRATA

Anche in tale ambito sanitario, la multidisciplinarietà e la presa in carico integrata sono requisiti indispensabili per l'attuazione di un sistema di cura che tenga conto della centralità e della globalità dei bisogni del malato, nel rispetto dell'autonomia culturale e professionale di ciascuna disciplina coinvolta.

Ad esempio, nella valutazione preoperatoria il team interdisciplinare dovrebbe essere costituito oltre che dal chirurgo bariatrico e dall'anestesista, dal medico internista, dal nutrizionista e dietista, dallo psicologo e dallo psichiatra (più eventuali altri professionisti per specifiche valutazioni).

FASI INTERVENTO PSICOLOGICO

Le azioni dello psicologo del team della chirurgia bariatrica si riferiscono a svariate fasi:

- accoglienza del paziente
- valutazione psicodiagnostica e selezione dei candidati
- preparazione all'intervento
- intervento psicologico durante il ricovero
- follow up.

L'intervento psicologico-psichiatrico non deve concludersi con l'intervento e la dimissione del paziente ma dovrebbe accompagnare il paziente, in quanto è proprio sul medio e lungo termine che i risultati risultano essere più critici.

VALUTAZIONE PSICOLOGICA E PSICHIATRICA

OBIETTIVI → il riconoscimento di disturbi psichiatrici che possono rappresentare controindicazioni all'intervento e il riconoscimento di tratti di personalità, comportamenti e disturbi psicopatologici minori associati all'obesità che devono essere oggetto di valutazione per la gestione del periodo post- operatorio.

DISTURBI NEUROCOGNITIVI→ Rappresentano controindicazioni all'intervento i quadri di **disturbi neurocognitivi** (es. delirium, demenza), disturbi correlati a sostanze, disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici, disturbi dissociativi, disturbi dell'umore gravi quali disturbo depressivo maggiore e disturbo bipolare.

I disturbi di personalità qualora i sintomi siano così gravi da invalidare la capacità di fornire un consenso valido all'intervento o siano correlati a ideazione suicidaria, grave impulsività, incapacità di conformarsi alle regole e indifferenza per la propria incolumità.

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

I disturbi del comportamento alimentare sono di particolare interesse in ambito bariatrico, non solo nella valutazione delle eventuali controindicazioni, ma anche nelle valutazioni del rischio post-operatorio.

Ad es. la bulimia nervosa è considerata una controindicazione mentre la presenza in anamnesi di un periodo di anoressia nervosa implica un elevato rischio di ricaduta con sintomi anoressico-bulimici nel post-operatorio.

Risulta quindi importante durante la valutazione indagare il rapporto con il corpo, l'immagine corporea e il comportamento alimentare.

I principali comportamenti alimentari disfunzionali da indagare, al fine di correggerli in funzione dell'intervento, sono: iperfagia prandiale, piluccamenti frequenti, frequenti infra-pasto, bramosie selettive, abbuffata compulsiva. Particolare attenzione merita il binge eating disorder.

Nel corso della valutazione è necessario ricostruire la storia del peso corporeo (cercando di individuare eventuali nessi cronologici tra importanti cambiamenti ponderali, eventi di vita e disturbi del comportamento alimentare) e la storia dei tentativi dietetici, di perdita del peso (motivazioni, risultati, utilizzo di farmaci).

CONSENSO E ADESIONE

La consulenza rappresenta un momento importante per chiarire se e quanto il paziente ha compreso delle procedure, dei rischi e delle conseguenze e se possa quindi fornire un consenso informato valido (attenzione a elementi psicopatologici).

Inoltre, occorre valutare la capacità di adesione al programma post-operatorio (compliance).

MOTIVAZIONI ALL'INTERVENTO

Il successo a lungo termine di un intervento di chirurgia bariatrica dipende, in buona misura, dalla motivazione del paziente e dalla sua tenuta nel tempo.

Le motivazioni possono essere di ordine medico e di ordine estetico.

- Al primo gruppo appartengono l'intenzione di combattere patologie internistiche (funzione curativa) e quella di contrastare rischi futuri (funzione preventiva).
- L'esplorazione dei motivi di ordine estetico (più frequenti nel genere femminile) è diretta a comprendere l'importanza che i pazienti attribuiscono al loro aspetto e a cogliere eventuali disturbi dell'immagine corporea.

In tutti i modelli teorici motivazionali sono distinti due concetti:

l'intenzione che costituisce la spinta iniziale e la motivazione che è costituita oltre che dall'intenzione anche dalla programmazione e attuazione del comportamento.

L'intenzione da sola non è sufficiente, è fondamentale far comprendere al paziente che l'atto chirurgico è solo un passo di un iter terapeutico che si compone di un lungo periodo di follow up caratterizzato da importanti cambiamenti (immagine del corpo, abitudini alimentari, equilibri familiari) che possono richiedere profondi processi di elaborazione psichica.

ASPETTATIVE

L'altro aspetto con cui entrare in contatto durante la valutazione riguarda le aspettative del paziente. Chi soffre di obesità ha spesso aspettative irrealistiche, "magiche" sia in termini quantitativi di calo ponderale sia qualitativi di miglioramenti estetici e tende quindi a sovrastimare gli effetti delle cure. È importante esaminare anche le aspettative dipendenti dal dimagrimento: molti pazienti attribuiscono all'obesità molti problemi (ansia, depressione, problemi familiari, carenza di autostima, problemi affettivo-relazionali, lavorativi) e si aspettano che l'intervento porti con sé la loro risoluzione. Aiutare i pazienti ad avere aspettative realistiche è fondamentale in quanto una quota rilevante dei fallimenti è attribuita proprio all'insoddisfazione soggettiva e alla delusione per i risultati.

VISSUTO PSICOLOGICO DEL PAZIENTE SOTTOPOSTO A TRAPIANTO D'ORGANO

PROCESSO:

1. **trapianto:** attesa, trapianto, post-trapianto
2. **donazione:** da cadavere, da vivente

DONAZIONE E PRELIEVO

Nella donazione e nel prelievo, affrontare i problemi emotivi e psicologici, significa confrontarsi con sentimenti molto intensi e contraddittori quali la disperazione per la perdita di un congiunto, la solitudine, il dolore, l'angoscia, la generosità, ecc., mentre, per chi riceve il trapianto, con la speranza, la gioia, il desiderio di vita.

Significa cioè ripensarsi e ripensare alla concezione di vita e di morte, che ciascuno di noi porta dentro di sé nel suo vissuto interiore e che esprime nella realtà dei rapporti con le altre persone.

Nei familiari, fattori emotivi, psicologici, culturali, religiosi, sociali, scarsa informazione, pregiudizi, difficoltà nell'accettare la sofferenza psichica e il dolore per la morte di un congiunto possono ostacolare la scelta di donazione.

Sollecitare i familiari di un paziente in stato di morte cerebrale, ad autorizzare il prelievo di organi, significa chiedergli di fare un duplice sforzo e cioè: prendere atto che null'altro è possibile fare per il proprio congiunto e, allo stesso tempo, superare l'immobilità dell'angoscia e del dolore con un gesto di altruismo e di solidarietà verso persone, quasi sempre sconosciute.

Una prima difficoltà rimanda alla complessità del concetto di cadavere a cuore battente e di morte diagnosticata con criteri neurologici, per cui i familiari devono fare i conti con il conflitto cognitivo ed emotivo che consegue alla diagnosi di morte in concomitanza all'immagine fisica di un corpo funzionante.

Dalla letteratura emerge una carenza di informazioni sul concetto di morte diagnosticata secondo criteri neurologici, sia nella popolazione generale che tra gli operatori sanitari.

Ricerche condotte sulla popolazione generale mostrano che la maggioranza di essa è inconsapevole, disinformata o possiede credenze non congruenti con le definizioni correnti di "morte cerebrale".

L'osservazione degli esami clinici, condotti per accertare lo stato della realtà della morte, sembra aiutare i familiari nella comprensione che il loro caro è deceduto ed è pertanto funzionale a promuovere il processo di lutto.

Un secondo aspetto problematico riguarda la difficoltà di interpretare la volontà rispetto alla donazione, soprattutto se non vi sono indicazioni in vita.

La letteratura evidenzia una stretta tra la precedente conoscenza della volontà del proprio caro, esplicita o inferita, e la successiva decisione dei familiari.

IL RUOLO DEGLI OPERATORI

Il ruolo degli operatori è importante nel determinare il consenso al prelievo

La conoscenza delle dinamiche emotive, psicologiche e relazionali, che si sviluppano in queste particolari circostanze, rappresenta un efficace strumento ed un valido aiuto.

È necessario che gli operatori siano adeguatamente informati e psicologicamente formati a gestire un evento da cui dipendono i destini di diverse persone.

TRAPIANTO

1. Lista d'attesa

L'inserimento in lista avviene solo dopo alcuni accertamenti, che in alcuni casi sono piuttosto lunghi ed invasivi. Possono già frustrare ed esaurire la persona.

Nel periodo della valutazione il paziente si sente sotto esame, e il suo timore è di non essere valutato idoneo.

Questo timore lo induce spesso a adottare un atteggiamento compiacente, poco autentico.

2. Attesa

- ✓ Sintomatologia: scompenso a carico di uno degli organi fondamentali per la vita
- ✓ Perdita di continuità esistenziale (lavoro, affetti, relazioni amicali)
- ✓ Perdita integrità corporea
- ✓ Perdita progettualità familiare
- ✓ Perdita ruolo familiare
- ✓ Esiti: perdita di controllo (locus of control esterno) e dipendenza dagli altri

Il paziente in attesa di trapianto vive un periodo della sua esistenza, privo di qualsiasi definitezza temporale, in un equilibrio instabile tra tendenze emotive intense:

- ➔ Speranza in una vita nuova e migliore (guarigione che il trapianto magicamente può donare)
- ➔ Terrore pervasivo che non arrivi l'organo compatibile e quindi che vi sia solo una prospettiva di lunga sofferenza che si conclude con la morte.
- ➔ Frustrazione e depressione per la perdita del proprio ruolo, familiare, sociale.

3. Reazioni emotive alla perdita di controllo del sé e della propria vita

- Ansia diffusa
- Depressione
- Stress
- Collera
- Paura

Nei confronti del trapianto in sé stesso

- Senso di colpa per l'attesa della morte di un donatore
- Senso di dipendenza dal fato, dagli altri
- Senso di precarietà, mancanza di un futuro programmabile

4. Dopo il trapianto

La terapia chirurgica del trapianto d'organo offre, senza ombra di dubbio, un sostanziale miglioramento della qualità di vita del paziente da un punto di vista strettamente fisico: lo scompenso causato dalla disfunzione d'organo viene completamente risolto.

Si apre invece la questione del benessere psicosociale del paziente

VISSUTI PAZIENTE TRAPIANTATO

- Condizione di paziente cronico di cui il trapiantato si rende conto pochi mesi dopo l'intervento: necessità di aderire a delle prescrizioni mediche non prive di conseguenze sulla propria vita (farmaci e loro effetti collaterali)
- Trauma legato all'esperienza vissuta: sensazione di aver affrontato e vinto la morte. Per alcuni ciò significa cadere in depressione, per altri sviluppare un senso di euforia e di onnipotenza ed invulnerabilità.
- Timore di nuove acutizzazioni, rigetto, possibilità di morire: senso di precarietà esistenziale.

IL PAZIENTE TRAPIANTATO

Può avere difficoltà nel gestire alcuni aspetti della sua vita:

- Tornare-trovare lavoro
- Rapporti sessuali ed affettivi con il partner
- Ruolo all'interno della propria famiglia
- Compliance

LE AREE DI INTERVENTO PSICOLOGICO

VALUTAZIONE:

- A. Paziente candidato a trapianto
- B. Potenziale donatore in caso di donazione da vivente

ASSISTENZA PSICOLOGICA RIVOLTA A:

- ✓ Paziente candidato a trapianto
- ✓ Paziente trapiantato
- ✓ Famiglia del paziente
- ✓ Donatore da vivente
- ✓ Famiglia donatore

L'IMPATTO DELLA MALATTIA SULLA FAMIGLIA E SULLE SUE RELAZIONI

Nel suo ciclo vitale la famiglia può trovarsi ad affrontare eventi traumatici, non previsti, come la malattia; per sopravvivere è obbligata a repentini cambiamenti in termini di riorganizzazione di ruoli e responsabilità.

Tale capacità di cambiare la struttura di potere, le relazioni di ruolo, le regole di relazione è definita adattabilità.

L'adattamento e il contenimento della sofferenza emotiva saranno più o meno efficaci sulla base della qualità delle relazioni familiari.

La malattia rappresenta un evento stressante per tutta la famiglia e può avere un effetto devastante su tutto il sistema di relazioni:

- ➔ nella maggioranza dei casi può creare una profonda rivalutazione delle priorità e rafforzare i legami.
- ➔ altre volte, la ristrutturazione che ne consegue può creare delle difficoltà sotto forma di modelli relazionali disfunzionali.

Si possono individuare dei fattori prognostici positivi di adattamento:

- ❖ coesione (i cui estremi ipercoinvolgimento e disimpegno sono considerati patologici)
- ❖ assenza di conflittualità
- ❖ adeguata espressività emotiva
- ❖ adattabilità (plasticità emotiva)
- ❖ stadio dello sviluppo
- ❖ organizzazione
- ❖ storia
- ❖ variabili culturali
- ❖ supporto sociale

LA COPPIA

- Tra i sottosistemi familiari, la relazione di coppia è quella che più risente della malattia, in quanto il ruolo del coniuge è riconosciuto come principale fornitore di supporto materiale ed emotivo
- Le problematiche riportate dai coniugi sono: ansia, incertezza, paure della morte e della malattia, aumentate richieste di vita quotidiana.
- La maggior parte delle coppie riporta che la relazione è rimasta immutata, e che è aumentata la coesione e l'affetto reciproco.
- Il deterioramento del rapporto di coppia è conseguenza di conflitti precedenti alla malattia.
- Un aspetto interessante è il rapporto di sostegno che il paziente offre al coniuge.
- Si è notato che il sostegno affettivo che il malato dà al coniuge sano alimenta il supporto che il coniuge stesso riuscirà a dare al congiunto malato, con una vera e propria reazione circolare

FIGLI

- Per quanto riguarda il sottosistema figli, numerosi studi hanno sottolineato la loro partecipazione alla sofferenza che sconvolge la famiglia.
- 1/3 dei figli: problematiche emotive che si evidenziano soprattutto con disturbi comportamentali (problemi scolastici, disturbi del sonno e dell'alimentazione, difficoltà di relazione con i coetanei, atteggiamenti aggressivi)
- L'entità dei problemi è correlata a situazioni di lunga durata, a scarso adattamento del genitore alla diagnosi e terapia, alla carenza di informazioni che il figlio ha ricevuto.
- Importante è la fase dello sviluppo psicologico del figlio, l'età, la personalità e il tipo di precedente rapporto col genitore.
 - ➔ 3-10 anni: sentimenti di solitudine, ansia e depressione, separazione e perdita associate a idee di colpa legate alla percezione di aver fatto ammalare il proprio genitore.
 - ➔ Pre-adolescenza: tentativi di auto-responsabilizzazione per tamponare le angosce legate alla percezione di fragilità e insicurezza della famiglia, mista a sentimenti di rabbia per la perdita del sostegno familiare
 - ➔ Adolescenza: sentimenti ambivalenti legati al conflitto tra i propri bisogni di autonomia, indipendenza e separazione da un lato, e i sentimenti di colpa determinati dalla consapevolezza di dover rinunciare alla libertà per sostenere il gruppo familiare in crisi.

RISCHI PSICOSOCIALI E STRESS NEI LUOGHI DI LAVORO

Chi non ha mai lavorato o lo ha fatto in modo occasionale percepisce il lavoro come una SOLUZIONE.

Chi invece lavora, o ha lavorato in modo continuativo, percepisce il lavoro come una fonte di PROBLEMI.

Al lavoro trascorriamo i migliori anni della nostra vita e le ore più belle della giornata

Perché?

SALUTE ➔ “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità” (OMS – art.2 D.Lgs 81/2008 smi)

IL CONCETTO DI RISCHIO PSICOSOCIALE

Aspetti della progettazione del lavoro, della sua organizzazione e gestione, e dei loro contesti sociali ed organizzativi, che hanno il potenziale di causare danni psicologici o fisici.

«Potenziale che le caratteristiche della situazione sociale ed organizzativa hanno di produrre una diminuzione, o di impedire l'aumento, del benessere, della salute e dell'incolumità delle persone»

1. i rischi che la situazione sociale faciliti prestazioni di sicurezza ridotte, quali ad esempio comportamenti a rischio, scarsa partecipazione alle iniziative di sicurezza, una comunicazione non funzionale al lavoro sicuro;
2. i rischi che la situazione sociale faciliti l'insorgenza di stress, burnout, mobbing, ma anche ad altri comportamenti negativi quali molestie di diverso tipo;
3. i rischi che la situazione sociale non consenta di cogliere le opportunità di crescita e di sviluppo delle persone nell'organizzazione



STRESS

Prospettive di studio dello stress:

- Approccio tecnico
- Approccio fisiologico
- Approccio psicologico: prospettiva transizionale

APPROCCIO FISIOLOGICO: SINDROME GENERALE DI ADATTAMENTO

- Selye (1936) definisce la *Sindrome Generale di Adattamento* come l'insieme delle risposte fisiologiche non specifiche agli agenti stressanti.

Lo stress è visto come una reazione aspecifica, adattiva di un organismo a qualunque esigenza, stimolato da minacce di svariata natura

- A. Stress “buono”, o **eustress**, generato da un’alterazione non patologica dell’equilibrio individuale, con funzione di adattamento (è un incontro positivo fra gli stimoli ambientali che spingono l'individuo ad un cambiamento, e le risorse di cui il soggetto dispone per affrontare tale cambiamento)
- B. Stress “cattivo”, o **distress**, generato da un turbamento negativo, patologico, dell’equilibrio individuale che nasce quando il confronto fra stimoli stressanti e risorse individuali volge a sfavore di queste ultime; questo tipo di stress può avere conseguenze assai dannose per l'individuo (malattie).

La SGA è composta da tre fasi:

1. **Reazione d'allarme**, ovvero una mobilitazione generale di tutte le forze difensive dell'organismo che avviene in seguito al primo impatto con l'agente nocivo; questa prima reazione consiste nell'attivazione del sistema nervoso autonomo, e nella conseguente comparsa di sintomi specifici e aspecifici
2. **Fase di resistenza**, ovvero l'organizzazione delle difese dell'organismo con conseguente strutturazione di un adattamento allo stimolo stressante
3. **Fase di esaurimento** in cui l'organismo cede alla forza degli stimoli stressanti e va incontro a conseguenze negative e irreversibili

APPROCCIO PSICOLOGICO TRANSIZIONALE

Lo stress consiste in una transazione tra l'individuo e l'ambiente nella quale la situazione è valutata dall'individuo come eccedente le proprie risorse e tale da mettere in pericolo il suo benessere (Lazarus, Folkman, 1984)

PERSONA (risorse personali) ↔ AMBIENTE (richieste)

Squilibrio = stress potenziale

Persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili

Una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili.

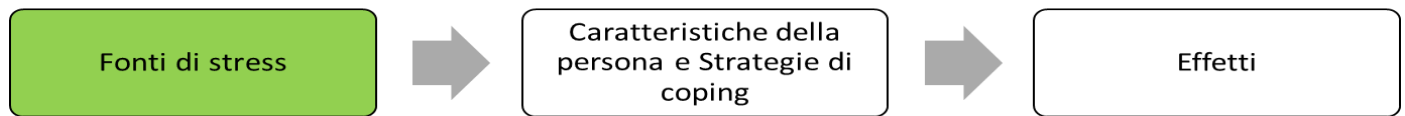
ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO – CORRELATO 8 OTTOBRE 2004

Lo stress è una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all'altezza delle aspettative.

STRESS LAVORO CORRELATO: RISCHIO TRASVERSALE



Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore.



CONTESTO LAVORATIVO	
CULTURA ORGANIZZATIVA	Scarsa comunicazione, bassi livelli di sostegno per la risoluzione di problemi e lo sviluppo personale, mancanza di definizione degli obiettivi organizzativi
RUOLO NELL'ORGANIZZAZIONE	Ambiguità e conflitto di ruolo, responsabilità di altre persone
SVILUPPO DI CARRIERA	Incertezza / blocco della carriera insufficienza / eccesso di promozioni, bassa retribuzione, insicurezza dell'impiego, scarso valore sociale attribuito al lavoro
AUTONOMIA DECISIONALE/CONTROLLO	Partecipazione ridotta al processo decisionale, carenza di controllo sul lavoro
RELAZIONI INTERPERSONALI SUL LAVORO	Isolamento fisico o sociale, rapporti limitati con i superiori, conflitto interpersonale, mancanza di supporto sociale
INTERFACCIA FAMIGLIA/LAVORO	Richieste contrastanti tra casa e lavoro, problemi di doppia carriera
CONTENUTI LAVORATIVI	
AMBIENTE DI LAVORO E ATTREZZATURE	Condizioni fisiche di lavoro, problemi inerenti l'affidabilità, la disponibilità, l'idoneità, la manutenzione o la riparazione di strutture ed attrezzature di lavoro
PIANIFICAZIONE DEI COMPITI	Monotonia, cicli di lavoro brevi, lavoro frammentato o inutile, sottoutilizzazione, incertezza elevata
CARICO/RITMI DI LAVORO	Sovraccarico o sottocarico di lavoro, mancanza di controllo sul ritmo, alti livelli di pressione temporale
ORARIO DI LAVORO	Lavoro a turni, orari di lavoro rigidi, imprevedibili, eccessivamente lunghi o che alterano i ritmi sociali.

COPING→ Sforzi della persona, sul piano cognitivo e comportamentale, per gestire le richieste interne ed esterne poste da quelle interrelazioni persona-ambiente che vengono valutate come eccedenti le risorse possedute

- ❖ Centrato sul problema
- ❖ Centrato sulle emozioni
- ❖ Centrato sull' evitamento

STRAIN→ Insieme negativo degli effetti/risposte che le fonti di stress presenti nei contesti lavorativi e organizzativi, interagendo con variabili di ordine individuale, ambientale e sociale, possono produrre nella persona:

- **STRAIN FISIOLOGICO** → Problemi al sistema cardio-vascolare; Ictus; Infezioni, ipersensibilità, cancro, ulcera; Esaurimento nervoso/attacchi d'ansia; Disturbi muscolo-scheletrici
- **STRAIN COMPORTAMENTALE**

COMPORTAMENTI SIGNIFICATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE	COMPORTAMENTI SIGNIFICATIVI PER L'INDIVIDUO
• Riduzione della performance • Turnover • Assenteismo/Presenteismo • Incidenti sul lavoro (errori e infortuni) • Cali di produttività • Aumento dei costi	• Alcol • Tabacco • Sostanze psicoattive

- **STRAIN PSICOLOGICO**
 - Tensione/ansietà
 - Fatica cronica o patologica
 - Depressione
 - Riduzione dell'autostima e della fiducia in se stessi
 - Diminuzione della motivazione
 - Esaurimento emotivo
 - Insoddisfazione lavorativa
 - Disimpegno verso l'organizzazione
 - Aggressività/violenza fisica
 - Burnout
 - Straining/ mobbing

UN PROBLEMA IMPORTANTE

Circa la metà dei lavoratori considera lo stress lavoro-correlato un fenomeno comune nel proprio luogo di lavoro.

È il secondo problema di salute più frequente legato all'attività lavorativa in Europa.

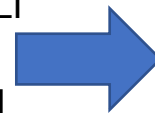
Il 50-60 % di tutte le giornate lavorative perse è riconducibile allo stress lavoro-correlato e ai rischi psicosociali.

Un lavoratore su sei ha problemi di salute mentale nel corso della vita lavorativa.

A livello nazionale, i costi dei rischi psicosociali sul lavoro si elevano a milioni di euro.

La gestione dello stress e dei rischi psicosociali sul lavoro è utile, dal momento che i benefici per l'azienda sono superiori ai costi di attuazione.

- PRESSIONI AMBIENTALI E POLITICO-SOCIALI
- ASPETTATIVE DELL'UTENZA
- COMPORTAMENTI/DECISIONI MANAGERIALI



**PRESSIONI
SULLA SANITA'**

BURNOUT → Sindrome di esaurimento emozionale, di depersonalizzazione e di riduzione delle capacità personali.

- Il termine *burnout* compare, per la prima volta, negli anni '30, nel gergo sportivo, ad indicare il fenomeno per il quale un atleta, dopo alcuni anni di successi, si esaurisce (si brucia) e non è più in grado di competere agonisticamente.
- Dagli anni '70 questo vocabolo entra nella terminologia dell'ambito lavorativo, in particolare con riferimento alle professioni di aiuto (cioè le professioni in cui ci si prende cura degli altri, come ad esempio operatori sanitari, psicologi, insegnanti, poliziotti, ecc.);
- Recentemente, si è iniziato a parlare di *burnout* anche per altri tipi di professione.

Si tratta di una reazione emozionale cronica creata dal contatto continuo con gli altri esseri umani, in particolare se essi hanno problemi o motivi di sofferenza (Maslach, 1976).

- ESAURIMENTO PERSONALE → sensazione di svuotamento delle risorse emotive, affettive e personali dell'individuo il quale si sente logorato, sopraffatto, incapace di "ricaricarsi" e di poter contribuire con il proprio lavoro alla soluzione dei problemi
- DEPERSONALIZZAZIONE → distacco ed ostilità nei confronti delle richieste d'aiuto, che portano a risposte negative, sgarbate e di freddezza nei confronti dei clienti/utenti e del proprio lavoro in generale
- RIDOTTA REALIZZAZIONE PERSONALE → percezione di inadeguatezza e di incompletezza nel lavoro da parte dell'operatore; essa si accompagna ad una caduta della stima di sé e del desiderio di successo nonché ad un generale senso di insoddisfazione lavorativa.

MOBBING→ Serie di azioni e pratiche ripetute che sono dirette contro uno o più lavoratori, che non sono volute dalla vittima, che possono essere messe in atto in maniera deliberata o inconsapevole, ma provocano chiaramente umiliazione, offesa e distress, e che possono interferire con la performance lavorativa e/o causare un ambiente lavorativo non piacevole.

- Forma di aggressione psicologica e morale sul lavoro
- Agita in modo prolungato nel tempo
- Più o meno intenzionale, svolta da uno o più aggressori
- Le azioni negative tendono a spingere la persona nella condizione di non potersi difendere e all'isolamento ed espulsione dal contesto lavorativo

SOGGETTI DEL MOBBING

1. **Mobbizzato:** si tratta del soggetto passivo, di colui che subisce i comportamenti discriminatori e vessatori.
2. **Mobber:** soggetto attivo, quello che pone in atto i comportamenti dannosi; nella maggior parte di casi si tratta di più soggetti, che effettuano un vero e proprio attacco di gruppo.
3. **Spettatori:** coloro che, pur non partecipando direttamente al mobbing, lo percepiscono, lo avvertono in quanto prende vita nell'ambiente in cui essi lavorano. Pur non interagendo direttamente nel conflitto, possono fornire al mobbizzato il sostegno sociale che lo stesso si aspetta e, quindi, far cessare le attività mobbizzanti attraverso una decisa presa di posizione a favore del soggetto attaccato. Oppure possono disinteressarsi di ciò che accade o addirittura avallare il mobbing (side-mobber).

DURATA E FREQUENZA

Il mobbing non si riferisce infatti ad eventi singoli ed isolati, ma a comportamenti che sono persistentemente e ripetutamente condotti nei riguardi di una o più persone. Leymann (1990, 1996) classifica come mobbing quegli eventi che si ripetono almeno una volta alla settimana, costituendo una seria forma di stress sociale.

Tuttavia, il criterio non è sempre facilmente applicabile poiché a volte le azioni aggressive hanno carattere permanente o non necessariamente episodico – ove ad esempio una persona sia costretta a lavorare in ambienti non salubri. Il criterio principale rimane quindi quello della continuità contrapposto all'occasionalità.

Quanto alla durata, Leymann suggerisce che si consideri mobbing un'esposizione a comportamenti negativi ed aggressivi superiore ai sei mesi. Il termine di sei mesi si giustifica con il fatto che il mobbing porta a seri danneggiamenti psicosomatici e psichiatrici, conseguenze che non derivano da normali stressor lavorativi; un periodo di sei mesi viene solitamente utilizzato nella valutazione di vari disordini psichiatrici; per questo motivo è stato proposto il termine di sei mesi come criterio per distinguere un insieme di azioni mobbizzanti da eventi sporadici.

COMPORTAMENTI MOBBIZZANTI

Sono stati individuate (Einarsen et al., 2002) alcune principali tipologie di comportamenti mobbizzanti:

1. cambiamento degli incarichi o delle mansioni lavorative della vittima in modo negativo, oppure le attività vengono rese più difficili e meno piacevoli da eseguire;
2. isolamento sociale indotto tramite la mancanza di comunicazione e l'esclusione dagli eventi sociali;
3. attacchi personali o riguardanti la sfera privata, condotti insultando, ridicolizzando o comportamenti simili;
4. minacce verbali tramite cui una persona viene criticata o umiliata in pubblico;
5. diffusione di dicerie riguardanti la vittima;
6. episodi di violenza fisica o minaccia di tale violenza;
7. attacchi alle credenze politiche o religiose della vittima.

Pur includendo fra le categorie di azioni mobbizzanti gli abusi fisici, molti autori concordano sul fatto che il fenomeno del mobbing si presenta soprattutto sotto forma di comportamenti di natura psicologica piuttosto che fisica.

ASIMMETRIA DI POTERE → Spesso la differenza di potere rispecchia il potere formale dell'organizzazione. Altre volte questo potere si gioca su un piano più informale, riguardando ad esempio le conoscenze e/o l'esperienza delle parti o il supporto di persone influenti.

VIOLENZA



RACCOMANDAZIONE PER PREVENIRE GLI ATTI DI VIOLENZA A DANNO DEGLI OPERATORI SANITARI

Gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari costituiscono eventi sentinella che richiedono la messa in atto di opportune iniziative di protezione e prevenzione

“ogni aggressione fisica, comportamento minaccioso o abuso verbale che si verifica nel posto di lavoro”

(NIOSH)

Concorrono all'incremento degli atti di violenza:

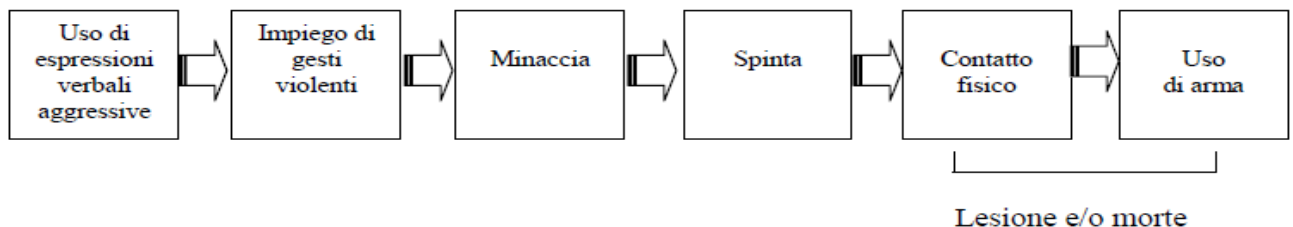
- l'aumento di pazienti con disturbi psichiatrici acuti e cronici dimessi dalle strutture ospedaliere e residenziali
- la diffusione dell'abuso di alcool e droga
- l'accesso senza restrizione di visitatori presso ospedali e strutture ambulatoriali
- lunghe attese nelle zone di emergenza o nelle aree cliniche, con possibilità di favorire nei pazienti o accompagnatori uno stato di frustrazione per l'impossibilità di ottenere subito le prestazioni richieste
- ridotto numero di personale durante alcuni momenti di maggiore attività (trasporto pazienti, visite, esami diagnostici)
- presenza di un solo operatore a contatto con il paziente durante visite, esami, trattamenti o gestione dell'assistenza in luoghi dislocati sul territorio ed isolati, quali i presidi territoriali di emergenza o continuità assistenziale, in assenza di telefono o altri mezzi di segnalazione e allarme
- mancanza di formazioni del personale nel riconoscimento e controllo dei comportamenti ostili e aggressivi
- scarsa illuminazione delle aree di parcheggio e delle strutture

In generale, gli eventi di violenza si verificano più frequentemente nelle seguenti aree:

- ➔ servizi di emergenza-urgenza (triage);
- ➔ strutture psichiatriche ospedaliere e territoriali;
- ➔ luoghi di attesa;
- ➔ servizi di geriatria;
- ➔ servizi di continuità assistenziale.

ESCALATION

Il comportamento violento avviene spesso secondo una progressione che, partendo dall'uso di espressioni verbali aggressive, arriva fino a gesti estremi quali l'omicidio. La conoscenza di tale progressione (vedi figura sottostante) può consentire al personale di comprendere quanto accade ed interrompere il corso degli eventi.



Alcuni tipi di violenza sono:

- a. minaccia di morte
- b. aggressione verbale a sfondo razziale, genere
- c. aggressione fisica
- d. aggressione a luoghi e cose
- e. aggressione verbale contro la professionalità
- f. ...

CONSEGUENZE SU PERSONA/E → Il contatto diretto o assistito con la violenza in ambito lavorativo espone l'operatore a vissuti dissonanti e fortemente contraddittori.

Da un lato l'operatore si trova investito del ruolo di "soccorritore" e portatore di cura, dall'altro vive la condizione di minaccia e aggressione, identificato spesso come rappresentante della "malasanità" e primo depositario di aspettative talvolta contrastanti.

L'operatore vittima di aggressione può sperimentare vissuti di ansia, insicurezza, paura per il futuro, somatizzazioni, nonché irritabilità, umore depresso, disturbi del sonno, affaticabilità.

- Disturbo Acuto da Stress
- Disturbo da Stress Post-Traumatico

CONSEGUENZE SU ORGANIZZAZIONE → La violenza può avere ripercussioni sull'organizzazione: i lavoratori aggrediti percepiscono negativamente l'ambiente di lavoro.

Pertanto, difficilmente esprimeranno il meglio delle loro attitudini lavorative in un ambiente dominato dal timore e dal risentimento.

Gli effetti negativi sull'organizzazione possono tradursi in maggiore assenteismo, perdita di motivazione e disaffezione lavorativa, riduzione della produttività, deterioramento dei rapporti di lavoro, rapido avvicendamento del personale e avviamento delle pratiche per il pensionamento anticipato.